BAİBÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ · HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

İzlemler
Çalışma Notu

Gebe · Lohusa · Yenidoğan ve Bebek · Çocuk · Okul Çağı ve Ergen · Erişkin ve Kronik Hastalık · Yaşlı

Her izlem tek tek: ne zaman yapılır, neler sorulur, neler ölçülür, ne beklenir, hangi aşı ve destek verilir, aileye ne anlatılır, bir sonraki izlem nasıl planlanır.

İçindekiler

Halk Sağlığı Hemşireliği – İzlemler Çalışma Notu

1. Bütün izlemlerde ortak olan akış

2. GEBE İZLEMİ

- 2.1 Genel bilgiler
- 2.2 Birinci izlem (ilk 14 hafta)
- 2.3 İkinci izlem (18–24. haftalar)
- 2.4 Üçüncü izlem (28–32. haftalar)
- 2.5 Dördüncü izlem (36–38. haftalar)
- 2.6 Her gebe izleminde mutlaka yapılanlar
- 2.7 Gebelikte tehlike belirtileri (gebeye ezberletilecek liste)
- 2.8 Örnek: "28 haftalık gebe izlemini anlat"

3. LOHUSA (DOĞUM SONU) İZLEMİ

- 3.1 Genel bilgiler
- 3.2 Her lohusa izleminde değerlendirilenler – baştan aşağı
- 3.3 Birinci lohusa izlemi (2.–5. gün)
- 3.4 İkinci lohusa izlemi (13.–17. gün)
- 3.5 Üçüncü lohusa izlemi (30.–42. gün)
- 3.6 Doğum sonu tehlike belirtileri (lohusaya öğretilecek liste)
- 3.7 Örnek: "Doğum sonu 4. gündeki lohusa izlemini anlat"

4. YENİDOĞAN VE BEBEK İZLEMİ (0–1 YAŞ)

- 4.1 Genel bilgiler ve izlem takvimi
- 4.2 Bebek izleminde ölçümler nasıl yapılır?
- 4.3 Birinci izlem – Doğumda (hastanede)
- 4.4 İkinci izlem – İlk hafta içinde (yenidoğan izlemi)
- 4.5 Üçüncü izlem – 15. gün
- 4.6 Dördüncü izlem – 41. gün
- 4.7 Beşinci izlem – 2. ay (aşı izlemi)
- 4.8 Altıncı izlem – 3. ay
- 4.9 Yedinci izlem – 4. ay
- 4.10 Sekizinci izlem – 6. ay
- 4.11 Dokuzuncu izlem – 9. ay
- 4.12 Bebeğin gelişimi – özet akış (ezber için)
- 4.13 Gelişimde uyarı işaretleri (hekime bildirilecek)
- 4.14 Bebekte tehlike belirtileri (aileye her izlemde öğretilecek)
- 4.15 Örnek: "6 aylık bebek izlemini anlat"

5. ÇOCUK İZLEMİ (1–6 YAŞ)

- 5.1 Genel bilgiler ve izlem takvimi
- 5.2 12. ay izlemi
- 5.3 18. ay izlemi
- 5.4 24. ay izlemi
- 5.5 30. ay izlemi
- 5.6 36. ay (3 yaş) izlemi
- 5.7 48. ay (4 yaş) izlemi
- 5.8 60. ay (5 yaş) izlemi – okula hazırlık

6. OKUL ÇAĞI VE ERGEN İZLEMİ (6–19 YAŞ)

- 6.1 Okul çağı (6–9 yaş) – yılda bir izlem
- 6.2 Ergen izlemi (10–19 yaş) – yılda bir izlem
- 6.3 Tüm çocukluk izlemlerinde: ihmal ve istismar belirtileri
- 6.4 Örnek: "18 aylık çocuk izlemini anlat"

7. ERİŞKİN, KRONİK HASTALIK VE YAŞLI İZLEMİ

- 7.1 Genel bilgiler
- 7.2 Sağlıklı erişkinin periyodik izlemi
- 7.3 Kan basıncının doğru ölçülmesi (her izlemin temeli)
- 7.4 Hipertansiyon izlemi
- 7.5 Diyabet izlemi
- 7.6 KOAH ve astım izlemi
- 7.7 Obezite ve kalp-damar riski izlemi
- 7.8 Yaşlı izlemi (65 yaş ve üzeri)
- 7.9 Örnek: "70 yaşında, hipertansiyon ve diyabeti olan yaşlının izlemini anlat"

8. EK: İZLEMLERDE YAPILAN AŞILAR (ÖZET)

9. EK: İZLEMLERDE VERİLEN DESTEKLER (ÖZET)

10. KENDİNİ TEST ET

Halk Sağlığı Hemşireliği – İzlemler Çalışma Notu

Bu not, Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) yapılan izlemleri baştan sona, izlem izlem anlatır: **gebe izlemi, lohusa izlemi, yenidoğan ve bebek izlemi, çocuk izlemi, okul çağı ve ergen izlemi, erişkin-kronik hastalık izlemi ve yaşlı izlemi.** Her izlemde ne zaman yapıldığını, neler sorulduğunu, neler ölçüldüğünü, hangi bulgunun normal hangisinin tehlikeli olduğunu, o izlemde hangi aşının ve desteğin verildiğini, aileye ne anlatıldığını ve bir sonraki izlemin nasıl planlandığını bulacaksın.

Değerlendirme formlarındaki ifade şu: "**Sağlık Bakanlığı izlem kriterleri doğrultusunda izlem yapabilme; izlem basamaklarını eksiksiz ve doğru şekilde değerlendirebilme/açıklayabilme**" ve "aşılar, ince/kaba motor gelişim, fiziksel gelişim vb. değerlendirilmesi, **bir sonraki ziyaretin planlanması**". Bu yüzden her izlemi şu soruların cevabını verebilecek kadar iyi bilmen gerekiyor: *Bu izlem ne zaman? Ne soruyorum? Ne ölçüyorum? Ne bekliyorum? Ne yapıyorum? Ne anlatıyorum? Bir sonraki izlem ne zaman ve orada ne olacak?*

> Dayanak rehberler: Sağlık Bakanlığı **Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi**, **Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi**, **Bebek, Çocuk, Ergen İzlem Protokolleri (2018)**, **Genişletilmiş Bağışıklama Programı**. İzlem gün aralıkları kaynaklara göre küçük farklılıklar gösterebilir; uygulamada ASM'nin kullandığı izlem formu ve rehber hemşirenin yönlendirmesi esastır.

---

1. Bütün izlemlerde ortak olan akış

Hangi izlemi yaparsan yap, izlem aynı mantıkla ilerler. Bunu bir kez iyice oturtursan her izlemde sadece "o yaşa/o haftaya özgü" kısmı eklemen yeter.

1. Hazırlık. Kişinin kaydını açıp önceki izlemi okursun: en son ne zaman gelmiş, ölçümleri neymiş, hangi aşılar yapılmış, hangi sorun not edilmiş, hangi tahlil istenmiş. Kullanacağın malzemeyi hazırlarsın (tartı, boy ölçer, mezura, tansiyon aleti, Doppler, persentil eğrisi, idrar şeridi, broşür).

2. Karşılama. Kendini tanıtır, kişinin kimliğini doğrular (ad-soyad ve doğum tarihi), izlemin amacını ve ne kadar süreceğini anlatıp izin alırsın. Mahremiyeti sağlarsın.

3. Öykü (anamnez). İzlemin en önemli kısmıdır. Son izlemden bu yana ne değişti, yakınması var mı, verilen öneriler uygulanmış mı, ilaçlar/destekler düzenli kullanılmış mı, kaygısı ne? Açık uçlu sorularla başlar ("Son geldiğinizden beri nasılsınız?"), sonra hedefe yönelik sorularla ilerlersin.

4. Fizik muayene ve ölçümler. Yaşa/duruma özgü ölçümler yapılır (bebekte ağırlık-boy-baş çevresi, gebede kan basıncı-kilo-fundus-fetal kalp sesi, kronik hastada kan basıncı-kan şekeri-bel çevresi). Ölçümler mutlaka **bir önceki ölçümle karşılaştırılır**; tek ölçüm değil, **gidişat** önemlidir.

5. Değerlendirme. Bulguları normal değerlerle karşılaştırırsın: Normal mi, dikkat gerektiriyor mu, acil mi? Risk varsa hekime bildirir, gerekirse sevk sürecini başlatırsın.

6. Koruyucu uygulamalar. O izlemde yapılması gereken aşı, demir/D vitamini/folik asit desteği, tarama testi (topuk kanı takibi, kalça ultrasonu, hemoglobin, kanser taraması) yapılır ya da yönlendirilir.

7. Eğitim ve danışmanlık. O döneme özgü konular anlatılır (beslenme, tehlike belirtileri, kaza önleme, emzirme, ilaç kullanımı). Anlattığını kişiye tekrar ettirerek (öğret-geri al yöntemi) anlaşıldığından emin olursun.

8. Kayıt. İzlem bilgileri ASM bilgi sistemine ve varsa izlem kartına eksiksiz işlenir.

9. Bir sonraki izlemin planlanması. Kişiye bir sonraki izlemin **tarihini** ve **o izlemde ne yapılacağını** söylersin ("15 gün sonra gelin, 2 aylık aşılarını yapacağız"). Ayrıca **beklemeden başvurması gereken durumları** (tehlike belirtilerini) tekrar hatırlatırsın.

> Değerlendirmede bir izlemi anlatırken bu dokuz basamağı sırayla söylemen ve her basamağın içini o izleme göre doldurman beklenir. En sık unutulanlar: önceki kaydı incelemek, ölçümü önceki ölçümle karşılaştırmak, tehlike belirtilerini anlatmak ve bir sonraki izlemi planlamak.

---

2. GEBE İZLEMİ

2.1 Genel bilgiler

Gebe izleminin amacı anne ve bebeğin sağlığını korumak, riskleri erken saptamak, gebeyi doğuma, doğum sonu döneme ve emzirmeye hazırlamaktır. Riskli olmayan her gebe **en az 4 kez** izlenir:

- **1. izlem:** Gebeliğin **ilk 14 haftası** içinde
- **2. izlem: 18–24.** haftalar arasında
- **3. izlem: 28–32.** haftalar arasında (bazı kaynaklarda 30–32)
- **4. izlem: 36–38.** haftalar arasında

Gebe 14. haftadan sonra ilk kez saptanmışsa, haftası ne olursa olsun yapılan ilk görüşme "1. izlem" olarak kabul edilir ve 1. izlemin tüm içeriği uygulanır. Risk saptanan gebelerde ya da gebenin isteğiyle izlem sayısı artırılır. Dört izlem bir **alt sınırdır**; gebe bu tarihler dışında da her yakınmasında başvurabilir.

Gebelik süresi son adet tarihinden itibaren yaklaşık **280 gün (40 hafta)**dır. 37. haftadan önceki doğum **erken doğum**, 37–42. haftalar arası **term**, 42. haftadan sonrası **geç (post-term)** doğumdur.

2.2 Birinci izlem (ilk 14 hafta)

İlk izlem en uzun ve en kapsamlı izlemdir; en az yarım saat ayrılması önerilir. Bu izlemde gebeliğin tamamına yön verecek bilgiler toplanır ve gebeliğin riskli olup olmadığına karar verilir.

Karşılama ve gebeliğin doğrulanması

Gebelik testi sonucu ve varsa ultrason bulgusu kontrol edilir. Gebelik planlı mı, istenen bir gebelik mi, kadının ve eşinin duyguları nasıl, sorulur. İstenmeyen gebelikte kadın yargılanmadan dinlenir ve hekime yönlendirilir.

Öykü – neleri soruyorum ve neden?

Kişisel bilgiler: Yaş (18 yaşından küçük ve 35 yaşından büyük gebelikler risklidir), eğitim durumu (eğitimin dilini ayarlamak için), çalışma durumu ve iş koşulları (ayakta çalışma, ağır kaldırma, kimyasal maruziyeti), sosyal güvence, kiminle yaşadığı, eş desteği.

Obstetrik öykü: Kaç kez gebe kaldığı (gravida), kaç doğum yaptığı (parite), düşük/küretaj sayısı (abortus) ve yaşayan çocuk sayısı sorulur ve kısaca "G3 P1 A1 Y1" şeklinde yazılır. Önceki doğumların şekli (normal mi sezaryen mi), önceki gebeliklerde yaşanan sorunlar (yüksek tansiyon/preeklampsi, gebelik şekeri, kanama, erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek, ölü doğum, doğum sonu kanama), son doğumdan bu yana geçen süre (iki doğum arası 2 yıldan kısaysa risk artar) öğrenilir.

Bu gebelik: Son adet tarihinin (SAT) ilk günü mutlaka sorulur; adetlerin düzenli olup olmadığı, SAT'tan emin olup olmadığı not edilir. Bulantı-kusmanın şiddeti, kanama, kasık ağrısı, akıntı, idrar yakınmaları sorulur.

Tıbbi öykü: Hipertansiyon, diyabet, kalp, böbrek, tiroid, epilepsi, astım, kansızlık, ruhsal hastalık gibi kronik hastalıklar; geçirilmiş ameliyatlar; kullanılan ilaçlar (bazı ilaçlar gebelikte değiştirilmelidir, bu nedenle ilaçlar hekime bildirilir), alerjiler, kan grubu biliniyorsa.

Aile öyküsü: Ailede diyabet, hipertansiyon, ikiz gebelik, kalıtsal hastalık, doğumsal anomali, akraba evliliği.

Yaşam tarzı: Sigara (pasif içicilik dahil), alkol, madde kullanımı; beslenme alışkanlıkları; fiziksel aktivite.

Psikososyal durum: Ruh hali, stres, destek kaynakları. Aile içi şiddet sorusu, kadın **yalnızken** ve güvenli bir ortamda, "Size evde zarar veren, sizi korkutan biri var mı?" gibi sakin bir dille sorulur.

Aşılar: Daha önce Td (tetanoz-difteri) aşısı olup olmadığı, kaç doz yapıldığı.

Hesaplamalar

Tahmini doğum tarihi (TDT) Naegele kuralıyla hesaplanır: **SAT'a 7 gün eklenir, 3 ay geri gidilir, 1 yıl eklenir.** Örneğin SAT 10 Mart 2026 ise: 10 Mart 2026 + 7 gün = 17 Mart 2026 → 3 ay geri = 17 Aralık 2025 → 1 yıl ekle = TDT **17 Aralık 2026**. Başka bir örnek: SAT 25 Mayıs 2026 → 1 Haziran 2026 → 1 Mart 2026 → TDT **1 Mart 2027**. Kısa yol: SAT (7 gün eklendikten sonra) Ocak, Şubat ya da Mart'a düşüyorsa doğum aynı yıl içinde, diğer aylarda ertesi yıl olur.

Gebelik haftası, SAT'tan bugüne geçen günlerin 7'ye bölünmesiyle bulunur. SAT bilinmiyorsa ya da adetler düzensizse ilk trimester ultrasonundaki ölçüm esas alınır.

Fizik muayene ve ölçümler

- **Boy ve kilo** ölçülür, **beden kitle indeksi (BKİ = kg/m²)** hesaplanır. Gebelik boyunca alınacak kilo buna göre belirlenir: zayıf kadın (BKİ 18,5 altı) 12,5–18 kg, normal kilolu (18,5–24,9) 11,5–16 kg, fazla kilolu (25–29,9) 7–11,5 kg, obez (30 ve üstü) 5–9 kg alabilir. BKİ'nin 18,5'in altında ya da 30'un üstünde olması risk faktörüdür.
- **Kan basıncı** doğru teknikle (5 dk dinlendikten sonra, oturur pozisyonda, kol kalp hizasında, uygun manşonla) ölçülür. İlk izlemdeki değer, sonraki izlemlerde karşılaştırma için "başlangıç değeri" olur. 140/90 mmHg ve üzeri yüksektir.
- **Nabız**, solukluk (kansızlık belirtisi), ödem, varis değerlendirilir.
- **Meme muayenesi** yapılır; meme başı yapısı (içe dönük meme başı) emzirme hazırlığı açısından not edilir.
- **Ağız-diş** durumuna bakılır; diş eti hastalıkları erken doğumla ilişkilendirildiğinden diş hekimine yönlendirilir.
- 10–12. haftadan sonra **Doppler ile fetal kalp sesi** dinlenebilir (normal 110–160/dk).

Laboratuvar ve ultrason

İlk izlemde genellikle şunlar istenir ya da sonuçları kontrol edilir:

- **Hemoglobin/hematokrit:** Kansızlığı saptamak için. Gebelikte hemoglobin **11 g/dl'nin altındaysa anemi** vardır (ikinci trimesterde sınır 10,5).
- **Kan grubu ve Rh:** Anne **Rh negatif** ise, bebek Rh pozitif olursa anne kanında antikor gelişebilir (Rh uyuşmazlığı). Bu nedenle indirekt Coombs testi yapılır ve hekim protokolüne göre 28. hafta civarında ve doğumdan sonra **anti-D immünglobulin** planlanır.
- **Tam idrar tetkiki:** İdrar yolu enfeksiyonu, belirti vermeyen bakteri varlığı (asemptomatik bakteriüri – tedavi edilmezse böbrek enfeksiyonu ve erken doğum riskini artırır) ve idrarda protein araştırılır.
- **Açlık kan şekeri:** Gebelikten önce var olan ama bilinmeyen diyabeti yakalamak için.
- **Hepatit B (HBsAg)** ve kurumun protokolüne göre diğer enfeksiyon testleri.
- **Ultrason:** Gebeliğin rahim içinde olduğunu, bebeğin kalp atımını, gebelik haftasını ve tek/çoğul gebelik olduğunu gösterir.
- **Kromozom tarama testleri** hakkında bilgi verilir: **11–14. haftalar** arasında **ikili test**, 15–20. haftalar arasında üçlü/dörtlü test. Bu testler isteğe bağlıdır, tanı koymaz, risk hesaplar; kadına bunlar anlatılarak karar vermesine yardım edilir.

Destekler

- **Folik asit:** Bebekte nöral tüp (omurilik) kusurlarını önlemek için **günde 400 mikrogram**, ideal olarak gebelikten önce başlanır ve **ilk 12 hafta** boyunca sürdürülür. Başlanmamışsa ilk izlemde hemen başlanır.
- **D vitamini:** Sağlık Bakanlığı programına göre **gebeliğin 12. haftasından sonra** başlanır ve **doğumdan sonra 6. ayın sonuna kadar** günde **1200 IU** verilir. Birinci izlemde başlangıç zamanı ve nasıl kullanılacağı anlatılır.
- **Demir: 16. haftadan (4. ay) itibaren** gebelik boyunca ve **doğumdan sonra 3 ay** süreyle günde 40–60 mg elementer demir verilir. Kansızlığı olan gebeye hekim tedavi dozu düzenler. Birinci izlemde demirin ne zaman başlanacağı söylenir.

Td aşısı

Gebelik tetanozu ve yenidoğan tetanozunu önlemek için gebenin aşı durumu kontrol edilir. Hiç aşılanmamış bir gebeye **Td1 gebeliğin 4. ayında** (ya da ilk temasta), **Td2 en az 4 hafta sonra** yapılır; **Td3 Td2'den 6 ay sonra, Td4 ve Td5 birer yıl arayla** tamamlanır. Daha önce aşılanmış kadın kaldığı dozdan devam eder; beş doz tamamlanmışsa 10 yılda bir rapel yeterlidir.

Risk değerlendirmesi

Topladığın bilgilere göre gebeliğin riskli olup olmadığına bakarsın. Risk göstergeleri: 18 yaşından küçük ya da 35 yaşından büyük olmak, çok sayıda doğum yapmış olmak, iki gebelik arasının kısa olması, önceki gebelikte preeklampsi, erken doğum, ölü doğum, doğum sonu kanama, sezaryen; kronik hastalık; çoğul gebelik; Rh uyuşmazlığı; anemi; BKİ'nin çok düşük ya da çok yüksek olması; sigara-alkol-madde; şiddet; sosyal destek yokluğu. Risk saptanırsa hekime bildirilir, izlem sıklığı artırılır ya da ikinci basamağa yönlendirilir.

Birinci izlemde anlatılacaklar

- **Bulantı-kusma:** İlk 3 ayda sıktır. Az ve sık yemek, sabah yataktan kalkmadan kuru kraker/ekmek yemek, yağlı-kokulu yiyeceklerden uzak durmak, sıvıları öğün aralarında içmek önerilir. Hiçbir şey tutamıyor, kilo kaybediyor, idrarı azalmışsa (hiperemezis) hemen başvurmalıdır.
- **Beslenme:** "İki kişilik yemek" gerekmez; dengeli ve çeşitli beslenmek yeterlidir. Ek enerji ihtiyacı daha çok ikinci ve üçüncü trimesterdedir. Her gün sebze-meyve, tam tahıl, süt ürünleri, et-yumurta-baklagil; günde 8–10 bardak su.
- **Kaçınılacaklar:** Alkol (güvenli bir miktarı yoktur), sigara ve sigara dumanı, çiğ ya da az pişmiş et ve yumurta, pastörize edilmemiş süt ve peynir (listeria riski), iyi yıkanmamış sebze-meyve, kedi kumu temizlemek (toksoplazma), hekime danışmadan ilaç ya da bitkisel ürün kullanmak. Kafein günde yaklaşık 2 fincan kahveyi geçmemelidir.
- **İlk trimesterde tehlike belirtileri: Vajinal kanama**, **kasık-karın ağrısı** (düşük ya da dış gebelik belirtisi olabilir), ateş, şiddetli kusma, idrarda yanma. Bunlardan biri olursa beklemeden başvurmalıdır.
- **Diş sağlığı**, kişisel hijyen, fiziksel aktivite (tempolu yürüyüş gibi orta şiddette egzersiz kontrendikasyon yoksa önerilir), çalışma koşulları.

Kayıt ve bir sonraki izlem

Tüm bilgiler kaydedilir; gebeye bir sonraki izlemin **18–24. haftalar** arasında olacağı, o izlemde bebeğin kalp sesinin dinleneceği, karnının ölçüleceği, ayrıntılı ultrason ve demir desteği konuşulacağı söylenir. Tahlil sonuçlarını ne zaman öğreneceği anlatılır.

2.3 İkinci izlem (18–24. haftalar)

Bu dönemde gebe genellikle bulantıdan kurtulmuştur, karnı belirginleşmiştir ve bebeğin hareketlerini hissetmeye başlamıştır.

Öykü

Son izlemden bu yana nasıl olduğu, bulantı-kusmanın geçip geçmediği, **bebek hareketlerini hissedip hissetmediği** (ilk gebelikte genellikle 18–20. haftada, daha önce doğum yapmışlarda 16–18. haftada hissedilir), kanama-akıntı-ağrı-idrar yakınmaları, baş ağrısı, ödem sorulur. Folik asit, D vitamini ve demirin düzenli kullanılıp kullanılmadığı, demirin yan etkileri (kabızlık, mide rahatsızlığı) sorulur. Birinci izlemde istenen tahlillerin sonuçları değerlendirilir.

Muayene ve ölçümler

- **Kan basıncı ve kilo**; önceki izlemle karşılaştırılır. Ani ve hızlı kilo artışı ödemi (preeklampsi) düşündürebilir.
- **Fundus yüksekliği:** Rahmin üst ucu (fundus) **20–22. haftada göbek hizasına** ulaşır. 16. haftada simfiz (kasık kemiği) ile göbeğin ortasında, 12. haftada kasık kemiğinin hemen üstündedir. 20. haftadan sonra fundus yüksekliği **mezura ile santimetre** olarak ölçülür: kasık kemiğinin üst kenarından fundusun en üst noktasına kadar ölçülen değer, **20–36. haftalar arasında yaklaşık gebelik haftasına eşittir** (±2 cm) – buna McDonald kuralı denir. Haftasına göre belirgin küçük ölçüm bebeğin gelişme geriliğini ya da sıvının azlığını; büyük ölçüm iri bebeği, sıvı fazlalığını ya da çoğul gebeliği düşündürür ve hekime bildirilir.
- **Fetal kalp sesi** Doppler ile dinlenir (110–160/dk).
- **Ödem** ve **idrarda protein** (idrar şeridiyle) değerlendirilir.

Taramalar ve destekler

- **Ayrıntılı (anomali) ultrason** genellikle **18–22. haftalar** arasında yapılır; yapılıp yapılmadığı ve sonucu kontrol edilir.
- **Demir desteği 16. haftada başlamış olmalıdır**; başlamamışsa başlanır, nasıl kullanılacağı anlatılır: aç karnına ya da öğün aralarında, portakal suyu gibi C vitamini içeren bir içecekle; **çay, kahve, süt ve kalsiyumla birlikte alınmaz** (en az 1–2 saat ara verilir). Dışkının siyahlaşabileceği, kabızlık yapabileceği anlatılır.
- **D vitamini** kullanımı sürdürülür.
- **Gebelik şekeri taraması (OGTT)** planlanır: **24–28. haftalar** arasında 75 gram şekerli sıvı içirilerek açlık, 1. saat ve 2. saat kan şekerine bakılır. Açlık 92, birinci saat 180, ikinci saat 153 mg/dl ve üstündeki değerlerden biri varsa **gestasyonel diyabet** tanısı konur. Gebeye testin nasıl yapılacağı anlatılır (gece 8–12 saat açlık, test süresince yememe-içmeme-sigara içmeme, oturarak bekleme).
- **Td aşısı** takvimine göre ikinci doz yapılır (Td1'den en az 4 hafta sonra).

Bu izlemde anlatılacaklar

- **Gebeliğin ikinci yarısındaki yakınmalar ve çözümleri:**
  - *Kabızlık:* Lifli besinler, bol su, yürüyüş. Demirin kabızlık yapabileceği hatırlatılır.
  - *Mide yanması:* Az ve sık yemek, yemekten sonra 2–3 saat uzanmamak, yatağın baş tarafını yükseltmek.
  - *Bel ağrısı:* Dik duruş, alçak topuklu ayakkabı, yerden bir şey alırken belden değil dizlerden eğilmek.
  - *Bacak krampları ve varis:* Bacakları yükseltmek, uzun süre ayakta kalmamak, bacak bacak üstüne atmamak, kramp anında ayak ucunu kendine doğru çekmek.
  - *Sırtüstü yatınca baş dönmesi:* Büyüyen rahim ana toplardamara bastığından **sol yana yatmak** önerilir.
- **Bebek hareketleri:** Hareketlerin artık düzenli hissedileceği anlatılır.
- **Gebe okulu/doğuma hazırlık eğitimine** katılım önerilir.
- **Tehlike belirtileri** (bu izlemden itibaren tam liste): vajinal kanama; şiddetli baş ağrısı; bulanık görme, gözlerde kararma; mide üstü ağrısı; yüzde ve ellerde ani şişme; havale; ateş; su gelmesi; bebek hareketlerinin azalması; zamanından önce düzenli kasılmalar.

Bir sonraki izlem

28–32. haftalar arasında. Gebeye OGTT'nin 24–28. haftalar arasında yaptırılması gerektiği, sonucuyla birlikte gelmesi söylenir.

2.4 Üçüncü izlem (28–32. haftalar)

Bu dönem preeklampsi ve erken doğum riskinin arttığı, bebeğin hızla kilo aldığı dönemdir. İzlemin odağı **kan basıncı, bebek hareketleri ve erken doğum belirtileri**dir.

Öykü

Baş ağrısı, görme bozukluğu, mide üstü ağrısı, yüz-el şişliği (preeklampsi belirtileri); bebek hareketleri; kasılma, bel ağrısı, akıntıda artış, su gelmesi (erken doğum belirtileri); kanama; idrar yakınmaları; uyku, nefes darlığı, yorgunluk sorulur. Demir ve D vitamini kullanımı, OGTT sonucu değerlendirilir.

Muayene ve ölçümler

- **Kan basıncı** en önemli ölçümdür. **20. haftadan sonra yeni ortaya çıkan 140/90 mmHg ve üstü** değer gebeliğe bağlı hipertansiyon; buna **idrarda protein** ya da baş ağrısı, görme bozukluğu, mide üstü ağrısı gibi belirtiler eşlik ediyorsa **preeklampsi** düşünülür ve gebe **hemen** hekime/hastaneye yönlendirilir. 160/110 ve üstü ağır tablodur.
- **Kilo** ve **ödem**: Ayak bileklerinde akşamları artan, dinlenmekle azalan ödem çoğunlukla normaldir; yüz ve ellerde, sabahları da süren, ani ödem tehlikelidir.
- **Fundus yüksekliği** (yaklaşık hafta kadar santimetre), **fetal kalp sesi**.
- 28. haftadan sonra **Leopold manevralarına** başlanabilir. Dört manevrayla sırasıyla şunlar anlaşılır: (1) Fundusta bebeğin hangi kısmı var (baş sert, yuvarlak ve hareketli; makat yumuşak ve düzensiz), (2) bebeğin sırtı annenin hangi tarafında (fetal kalp sesi en iyi sırt tarafında duyulur), (3) rahmin alt kısmında (pelvise doğru) hangi kısım var, (4) baş pelvise girmiş mi (angajman). Bu izlemde bebek henüz dönebilir; kesin geliş 36. haftada değerlendirilir.
- **Hemoglobin** üçüncü trimesterde tekrar kontrol edilir.

Bu izlemde yapılanlar

- **OGTT sonucu** değerlendirilir; gestasyonel diyabet varsa hekime yönlendirilir, beslenme ve kan şekeri izlemi planlanır.
- **Rh negatif** anneye hekim protokolüne göre **28. hafta civarında anti-D** uygulanması planlanır.
- **Td** takvimi kontrol edilir.

Bu izlemde anlatılacaklar

- **Bebek hareketlerinin sayılması:** 28. haftadan sonra gebe, bebeğin genellikle hareketli olduğu bir saatte (yemekten sonra, sol yanına uzanarak) hareketleri sayar. **İki saat içinde 10 hareketten az** hissediyorsa ya da hareketlerde belirgin azalma varsa **beklemeden** hastaneye başvurmalıdır.
- **Erken doğum belirtileri:** 37. haftadan önce düzenli ağrılı kasılmalar, belde sürekli ağrı, kasıkta baskı hissi, akıntının sulanması ya da artması, su gelmesi, kanama.
- **Preeklampsi belirtileri** tekrar anlatılır.
- **Doğuma hazırlık:** Doğumun nerede yapılacağı, hastaneye nasıl gidileceği, doğum çantası.
- **Emzirmeye hazırlık:** Doğumdan sonraki ilk 1 saat içinde emzirmeye başlamanın, ilk 6 ay yalnızca anne sütü vermenin önemi; ilk günlerdeki sarı ve koyu sütün (kolostrum) bebeğin ilk aşısı gibi olduğu.
- **Uyku ve dinlenme:** Sol yana yatma, bacak arasına yastık.

Bir sonraki izlem

36–38. haftalar arasında. Tehlike belirtileri ve bebek hareketlerinin sayılması bir kez daha hatırlatılır.

2.5 Dördüncü izlem (36–38. haftalar)

Doğum yaklaşmıştır. Bu izlemin odağı **bebeğin gelişi (baş mı makat mı), doğum belirtileri, doğum planı ve doğum sonu döneme hazırlık**tır.

Öykü

Bebek hareketleri, kasılmalar, akıntı, kanama, su gelmesi, baş ağrısı-görme bozukluğu-ödem, idrar yakınmaları, uyku ve kaygı durumu sorulur. Doğum korkusu varsa konuşulur.

Muayene

- **Kan basıncı, kilo, ödem, idrarda protein.**
- **Fundus yüksekliği:** 36. haftada fundus en yüksek noktasına, **göğüs kemiğinin uç kısmının (ksifoid) hemen altına** ulaşır; doğuma yakın bebeğin başı pelvise indiğinde fundus biraz aşağı iner ve gebe nefes almakta rahatladığını söyler.
- **Leopold manevraları** ile bebeğin gelişi değerlendirilir. **Baş geliş** normaldir. **Makat ya da enine geliş** saptanırsa hekime bildirilir ve doğum yeri planı buna göre yapılır.
- **Fetal kalp sesi.**

Bu izlemde anlatılacaklar

- **Doğum başladığının belirtileri:**
  - **Düzenli, giderek sıklaşan ve şiddetlenen ağrılı kasılmalar** (ilk doğumda kasılmalar yaklaşık 5 dakikada bir gelmeye başlayıp bir saat boyunca devam ediyorsa hastaneye gidilir).
  - **Kanlı nişan:** Rahim ağzını kapatan mukus tıkacının pembe-kanlı bir akıntı şeklinde gelmesi.
  - **Su gelmesi:** Kese açıldığında kasılma olmasa bile **hemen** hastaneye gidilmelidir.
  - Yalancı kasılmalar düzensizdir, dinlenince ya da pozisyon değiştirince azalır.
- **Doğum çantası:** Kimlik, gebelik takip belgeleri, anne için gecelik-iç çamaşırı-lohusa pedi, bebek için kıyafet-battaniye-zıbın.
- **Emzirme:** İlk 1 saatte ten tene temas ve emzirme; bebeğin isteğine göre sık emzirme; ilk günlerde süt az gibi görünse de kolostrumun yeterli olduğu; biberon ve mama ile takviye yapılmaması.
- **Doğum sonu dönem:** Lohusalıkta tehlike belirtileri, doğumdan sonra demir (3 ay) ve D vitamininin (6 ay) devam edeceği, lohusa izlemlerinin zamanları.
- **Doğum sonu aile planlaması danışmanlığı:** Emziren annelere uygun yöntemler, doğumdan sonra ne zaman başlanabileceği, iki doğum arasında en az 2 yıl bırakmanın önemi.
- **Yenidoğana hazırlık:** Bebeğin ilk saatlerde K vitamini ve Hepatit B aşısı alacağı, 48 saatten sonra topuk kanı alınacağı, işitme taraması yapılacağı, bebeğin ilk izlemlerinin zamanları.
- **Gebelik 41. haftayı geçerse** hastane değerlendirmesi gerektiği.

Bir sonraki izlem

Doğumdan sonra **lohusa ve yenidoğan izlemi**. Aileye doğumdan sonra ASM'ye bilgi vermeleri ve ilk hafta içinde ev ziyareti ya da ASM izlemi yapılacağı söylenir.

2.6 Her gebe izleminde mutlaka yapılanlar

Hangi izlem olursa olsun şunlar atlanmaz:

- Gebelik haftasını hesaplamak
- Kan basıncı, kilo, ödem değerlendirmesi
- (12. haftadan sonra) fetal kalp sesi, (20. haftadan sonra) fundus yüksekliği
- Bebek hareketleri (hissedilmeye başladıktan sonra)
- Tehlike belirtilerini sorgulamak ve anlatmak
- Demir, D vitamini, folik asit kullanımını sorgulamak
- Td durumunu kontrol etmek
- Riskleri yeniden değerlendirmek
- Kayıt ve bir sonraki izlemin planlanması

2.7 Gebelikte tehlike belirtileri (gebeye ezberletilecek liste)

Aşağıdakilerden **biri bile** varsa gebe **beklemeden** en yakın hastaneye başvurmalıdır:

1. Vajinal kanama
2. Şiddetli ve geçmeyen baş ağrısı
3. Bulanık görme, gözlerde kararma, ışık çakması
4. Mide üstünde ya da sağ üst karında ağrı
5. Yüzde, ellerde ani şişme
6. Havale (nöbet), bilinç bulanıklığı
7. Ateş (38 °C ve üstü), titreme
8. Bebek hareketlerinin azalması ya da hiç hissedilmemesi
9. Su gelmesi
10. 37. haftadan önce düzenli kasılmalar, belde sürekli ağrı
11. Durmayan kusma, idrar yaparken yanma ile ateş, nefes darlığı, şiddetli karın ağrısı

2.8 Örnek: "28 haftalık gebe izlemini anlat"

> "Önce gebenin kaydını açarım: önceki kan basıncı ve kilo değerlerini, hemoglobin sonucunu, OGTT'nin yapılıp yapılmadığını, Rh durumunu ve Td aşılarını kontrol ederim. Gebeyi karşılar, kendimi tanıtıp izin alırım. Baş ağrısı, görme bozukluğu, mide üstü ağrısı, yüz-el şişliği olup olmadığını; kanama, su gelmesi, kasılma ve bel ağrısı olup olmadığını; bebeğin hareketlerini nasıl hissettiğini sorarım. Demir ve D vitaminini düzenli kullanıp kullanmadığını, kabızlık gibi yan etkileri sorarım. Kan basıncını doğru teknikle ölçer, önceki değerle karşılaştırırım; kilosunu tartar, ödeme bakarım. İdrarda protein bakarım. Fundus yüksekliğini mezurayla ölçerim, yaklaşık 28 santimetre beklerim. Doppler ile bebeğin kalp sesini dinlerim, 110–160 arasında olmalı. Leopold manevralarına başlayabilirim. OGTT sonucunu değerlendiririm; Rh negatifse anti-D uygulamasını hekime hatırlatırım. Gebeye bebek hareketlerini nasıl sayacağını öğretirim: iki saatte en az 10 hareket hissetmeli, azalırsa beklemeden hastaneye gitmeli. Tehlike belirtilerini ve erken doğum belirtilerini tekrar anlatırım, sol yana yatmasını, demiri çayla değil portakal suyuyla almasını hatırlatırım. Her şeyi kaydeder, bir sonraki izlemin 36–38. haftalar arasında olduğunu ve o izlemde bebeğin gelişini değerlendirip doğum planını konuşacağımızı söylerim."

3. LOHUSA (DOĞUM SONU) İZLEMİ

3.1 Genel bilgiler

Lohusalık, doğumdan sonraki **6 haftalık (42 günlük)** dönemdir. Bu dönemde rahim ve diğer üreme organları gebelik öncesi durumuna döner, emzirme başlar ve yerleşir, anne yeni rolüne uyum sağlar. Anne ölümlerinin önemli bir kısmı doğumdan sonraki ilk günlerde ve haftalarda (kanama, enfeksiyon, preeklampsi, pıhtı) olduğu için lohusa izlemi en az gebe izlemi kadar önemlidir.

Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberine göre lohusa, **ilk 24 saat** hastanede izlenir (normal doğumda en az 24 saat, sezaryende en az 48 saat hastanede kalış önerilir). **Taburculuktan sonra 42. güne kadar** ASM'de ya da evde izlenir. Taburculuk sonrası en az 3 izlem yapılır; ders kitaplarında en sık geçen zamanlama şöyledir:

- **1. izlem: 2.–5. gün** (çoğunlukla ev ziyareti ya da ASM'de bebek izlemiyle birlikte)
- **2. izlem: 13.–17. gün** (yaklaşık 2. hafta – bebeğin 15. gün izlemiyle birlikte)
- **3. izlem: 30.–42. gün** (yaklaşık 4.–6. hafta – bebeğin 41. gün izlemiyle birlikte)

> Bazı kaynaklar bu zamanlamayı "ilk 24 saat, 2. hafta ve 4–6. hafta" şeklinde verir. Pratikte en iyi yol, **lohusa izlemlerini bebek izlemleriyle aynı güne denk getirmektir**: anne ve bebek birlikte gelir, ikisi birlikte değerlendirilir.

3.2 Her lohusa izleminde değerlendirilenler – baştan aşağı

Lohusa izleminde kolay hatırlamak için **baştan aşağı** gidersin: genel durum ve vital bulgular → memeler → rahim (fundus) → loşia → perine ya da sezaryen yarası → mesane ve bağırsak → bacaklar → duygu durumu → beslenme, dinlenme, destekler → aile planlaması.

Genel durum ve vital bulgular

- **Ateş:** Doğumdan sonraki ilk 24 saatte hafif ateş (38 °C'nin altında) sıvı kaybına bağlı olabilir. **24 saatten sonra 38 °C ve üstü ateş** enfeksiyonu (rahim, meme, idrar yolu, yara) düşündürür ve hekime bildirilir.
- **Nabız:** Hızlı nabız kanama ya da enfeksiyon belirtisi olabilir.
- **Kan basıncı:** Preeklampsi doğumdan sonra da (özellikle ilk hafta) ortaya çıkabilir. Yüksek kan basıncı ile baş ağrısı, görme bozukluğu, mide üstü ağrısı birlikteyse acildir. Gebelikte yüksek tansiyonu olan annelerde kan basıncı her izlemde izlenir.
- **Solukluk, halsizlik, baş dönmesi:** Kansızlık belirtileri.

Memeler

Memeler gözle ve elle değerlendirilir. İlk 2–3 gün **kolostrum** (sarı, koyu, az miktarda) gelir; 3.–5. günlerde süt artar ve memeler dolgunlaşır (sütün gelmesi). Bakılacaklar: meme başında çatlak, kızarıklık, yara; memelerde aşırı dolgunluk, sertlik, ağrı (angorjman); memenin bir bölümünde kızarık, sıcak, ağrılı alan ve ateş (mastit). Emzirme mutlaka **gözlemlenir** (aşağıda ayrıntılı).

Rahim (fundus) – involüsyon

Rahmin gebelik öncesi boyutuna dönmesine **involüsyon** denir. Lohusa sırtüstü yatar, dizlerini hafifçe büker, mesanesini önceden boşaltmış olmalıdır (dolu mesane rahmi yukarı iter ve kasılmasını engeller). Bir el kasık kemiğinin üstüne konup rahim desteklenirken diğer el göbekten aşağı doğru fundus aranır.

- Doğumdan hemen sonra fundus **göbek hizasında ya da hemen altında**, **sert ve top gibi** kasılmış hissedilir.
- İlk 12 saatte göbek hizasına ya da 1 parmak üstüne çıkabilir.
- Sonra **her gün yaklaşık 1 cm (bir parmak eni)** aşağı iner. Örneğin 3. günde göbeğin yaklaşık 3 parmak, 5. günde 4–5 parmak altındadır.
- **10.–14. günde** artık karından ele gelmez (pelvise iner).
- **6. haftada** gebelik öncesi boyutuna döner.
- Rahim **yumuşak ve gevşek** ise ya da beklenenden yukarıdaysa **kanama riski** vardır: rahme nazikçe masaj yapılır, mesanenin boşaltılması sağlanır, bebek emzirilir (emzirme rahmi kastırır) ve hemen hekime bildirilir.
- Emzirirken hissedilen kramp tarzı ağrılar (rahim kasılmaları, "akıntı sancısı") özellikle daha önce doğum yapmış kadınlarda normaldir.

Loşia (doğum sonu akıntısı)

- **Loşia rubra (1.–3./4. gün):** Kırmızı, kanlı, küçük pıhtılar olabilir.
- **Loşia serosa (4.–10. gün):** Pembe-kahverengi, daha sulu.
- **Loşia alba (10. günden 2.–6. haftaya):** Sarımsı-beyaz.

Değerlendirirken miktarına, rengine, kokusuna ve pıhtı olup olmadığına bakılır. **Normal loşia** adet kanaması gibi hafif bir kokudadır. **Kötü koku** enfeksiyonu; **miktarın artması, büyük pıhtılar, akıntının yeniden kırmızıya dönmesi** kanamayı ya da rahimde parça kaldığını düşündürür ve hekime bildirilir. "Bir saatte bir pedi tamamen ıslatacak kadar kanama" acil durumdur.

Perine (epizyotomi/yırtık) ya da sezaryen yarası

Perine, lohusa yan yatarken ve iyi ışıkta değerlendirilir. Değerlendirme beş bulguyla yapılır (**REEDA**): **kızarıklık, ödem (şişlik), morarma (ekimoz), akıntı ve yara kenarlarının birbirine yaklaşıp yaklaşmadığı.** Ağrı, şişlik ve kötü kokulu akıntı enfeksiyonu düşündürür. Hemoroid de kontrol edilir. Sezaryenle doğum yapan annede yara yeri kızarıklık, akıntı, açılma, şişlik ve ağrı yönünden değerlendirilir; yara bakımı ve hijyen anlatılır.

Mesane ve bağırsak

İdrarını rahat yapıp yapamadığı, yanma, idrar kaçırma; dışkılama ve kabızlık sorulur. Doğumdan sonra ilk günlerde idrar miktarının artması normaldir. Kabızlık için lifli beslenme, bol sıvı ve hareket önerilir.

Bacaklar

Her iki bacak karşılaştırılır. **Tek taraflı ağrı, şişlik, kızarıklık, ısı artışı** derin ven trombozunu (bacakta pıhtı) düşündürür; pıhtı akciğere gidebileceği için **acil** yönlendirme gerekir. Erken hareket (doğumdan kısa süre sonra yürümeye başlama) ve bol sıvı pıhtı riskini azaltır.

Duygu durumu

- **Lohusa hüznü (baby blues):** Kadınların çoğunda görülür. Doğumdan **2–3 gün sonra** başlar; ağlamaklılık, duygusal dalgalanma, alınganlık, kaygı ve yorgunluk olur. **İki hafta içinde kendiliğinden geçer.** Dinlenme, uyku, aile desteği ve kadının duygularının normal olduğunun anlatılması yeterlidir.
- **Doğum sonu depresyon:** Belirtiler **iki haftadan uzun sürer** ve günlük yaşamı bozar: sürekli üzgünlük, umutsuzluk, değersizlik hissi, bebeğe ilgisizlik ya da bebeğe bakamayacağı düşüncesi, uyku ve iştah bozukluğu, kendini suçlama. Bu durumda **hekime yönlendirilir**. Taramada **Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği** (10 soru) kullanılabilir; Türkçe çalışmada **13 ve üzeri** puan risk olarak kabul edilir.
- **Doğum sonu psikoz:** Nadirdir; ilk haftalarda gerçek dışı sesler duyma, şüphecilik, aşırı hareketlilik, bebeğe zarar verme düşünceleri olur. **Acil** durumdur.

Beslenme, dinlenme ve destekler

- Emziren anne dengeli beslenmeli, susadıkça su içmelidir; emzirme için günde yaklaşık 500 kcal ek enerji gerekir. Zayıflama diyeti ilk haftalarda önerilmez.
- **Demir** desteği **doğumdan sonra 3 ay**, **D vitamini** desteği **doğumdan sonra 6 ay** boyunca sürdürülür.
- Bebek uyurken uyumak, ev işlerinde yardım almak önerilir.

Aile planlaması

Her izlemde konuşulur; üçüncü izlemde bir yöntem seçilmiş olması hedeflenir (ayrıntılar aşağıda).

3.3 Birinci lohusa izlemi (2.–5. gün)

Bu izlem genellikle hastaneden çıktıktan sonraki ilk günlerde, çoğunlukla bebeğin ilk izlemiyle birlikte yapılır. Kanama, enfeksiyon, preeklampsi ve emzirme sorunlarının en sık görüldüğü dönemdir.

Öyküde doğumun şekli ve tarihi, doğumda sorun olup olmadığı (kanama, yırtık, epizyotomi, sezaryen nedeni), taburculukta söylenenler, şu an ağrı, kanama, ateş, baş ağrısı, idrar-dışkılama, uyku ve emzirme sorulur. **Muayenede** ateş, nabız, kan basıncı ölçülür; memeler, fundus (göbeğin 2–5 parmak altında ve sert olmalı), loşia (rubra; 4. günden itibaren serosaya dönmeye başlar), perine ya da sezaryen yarası, bacaklar değerlendirilir.

Bu izlemin en önemli parçası **emzirmenin gözlenmesidir**. Annenin bebeği nasıl tuttuğu ve bebeğin memeyi nasıl kavradığı izlenir:

- **Doğru tutuş:** Bebeğin kulağı, omzu ve kalçası düz bir çizgi üzerinde; bebeğin karnı annenin karnına dönük; bebeğin burnu meme başı hizasında; anne bebeği memeye getirir, memeyi bebeğe doğru eğilerek uzatmaz.
- **Doğru kavrama:** Bebeğin **ağzı geniş açık**, **alt dudağı dışa dönük**, **çenesi memeye değiyor**, areolanın (meme başı çevresindeki koyu bölge) **üst kısmı alt kısmından daha fazla görünüyor**. Bebek yavaş ve derin emer, yutkunduğu duyulur, yanakları dolgundur (çukurlaşmaz), anne meme başında ağrı hissetmez.
- Yanlış kavramada bebek yalnızca meme başını emer; bu hem meme başı çatlağına hem de bebeğin yeterli süt alamamasına yol açar. Annenin serçe parmağını bebeğin ağzının kenarından sokarak emmeyi nazikçe sonlandırması ve bebeği yeniden doğru biçimde memeye yerleştirmesi öğretilir.

Anlatılacaklar: Bebeğin isteğine göre, gece dahil günde **8–12 kez** emzirme; bir memeyi boşaltıp sonra diğerine geçme; mama, su, şekerli su verilmemesi; sütün 3.–5. günlerde artacağı ve memelerin dolgunlaşacağı; **perine hijyeni** (her tuvaletten sonra önden arkaya doğru temizlik, pedin sık değiştirilmesi, ped değişiminden önce ve sonra el yıkama); dinlenme ve beslenme; demir ve D vitamininin sürdürülmesi; **doğum sonu tehlike belirtileri** (aşağıdaki liste). Annenin duygu durumu sorulur, lohusa hüznünün normal olduğu anlatılır.

Bir sonraki izlem: 13.–17. günler arasında (bebeğin 15. gün izlemiyle birlikte).

3.4 İkinci lohusa izlemi (13.–17. gün)

Bu dönemde fundus artık karından ele gelmemelidir, loşia serosadan albaya geçmektedir, emzirme yerleşmiş olmalıdır ve lohusa hüznü geçmiş olmalıdır.

Öyküde kanama ve akıntının nasıl olduğu, ağrı, ateş, idrar ve dışkılama, emzirmenin nasıl gittiği, memelerde sorun, uyku, yorgunluk ve **ruh hali** sorulur. **Muayenede** vital bulgular, memeler, fundus (palpe edilmemeli; hâlâ göbeğin hemen altında ve büyükse involüsyon gecikmiştir → hekim), loşia, perine/yara iyileşmesi, bacaklar değerlendirilir.

Bu izlemde özellikle şunlara odaklanılır:

- **Duygu durumu:** Hüzün belirtileri iki haftayı geçmişse doğum sonu depresyon açısından değerlendirilir; Edinburgh ölçeği uygulanabilir.
- **Emzirme sorunları:**
  - *Meme başı çatlağı:* En sık nedeni yanlış kavramadır; kavrama düzeltilir, emzirmeye az ağrıyan memeden başlanır, emzirme sonrası birkaç damla süt meme başına sürülüp kurumaya bırakılır, sabun ve alkolle meme başı silinmez.
  - *Memelerde aşırı dolgunluk (angorjman):* Sık ve etkili emzirme, gerekirse emzirmeden önce biraz süt sağma; emzirmeden önce ılık, sonra soğuk uygulama.
  - *Tıkalı süt kanalı:* O memeden sık emzirme, farklı emzirme pozisyonları, nazik masaj, sıkı sütyen giymeme.
  - *Mastit (memede kızarık, sıcak, ağrılı alan + ateş):* Emzirmeye devam edilir (önce etkilenen memeden), dinlenme, sıvı alımı ve **hekime yönlendirme**.
  - *"Sütüm yetmiyor" kaygısı:* Bebeğin yeterli süt aldığının göstergeleri anlatılır: günde 6 ve üzeri ıslak bez, sarı-yumuşak dışkı, emzirme sonrası rahatlama ve düzenli kilo alımı. Bebeğin doğum ağırlığına dönüp dönmediği bebek izleminde birlikte değerlendirilir.
- **Pelvik taban egzersizleri (Kegel):** İdrarı tutuyormuş gibi pelvik kasların 5–10 saniye kasılıp gevşetilmesi, günde birkaç set.
- **Aile planlaması danışmanlığı** başlatılır.

Bir sonraki izlem: 30.–42. günler arasında (bebeğin 41. gün izlemiyle birlikte).

3.5 Üçüncü lohusa izlemi (30.–42. gün)

Bu izlem lohusalığın sonunu değerlendirir. İnvolüsyon tamamlanmış, loşia sona ermiş ya da sona ermek üzere, perine ve sezaryen yarası iyileşmiş olmalıdır.

Değerlendirilenler: Genel durum, kan basıncı, kilo; loşianın bitip bitmediği; perine/yara iyileşmesi; idrar kaçırma; emzirmenin durumu; duygu durumu (depresyon taraması); kansızlık belirtileri (gerekirse hemoglobin); demir ve D vitamini kullanımı.

Gebelikte sorun yaşamış annelerde:

- Gebelikte **şeker** (gestasyonel diyabet) çıkmışsa, doğumdan **4–12 hafta sonra** şeker yükleme testi (OGTT) yapılması için hekime yönlendirilir; çünkü bu kadınlar ileride tip 2 diyabet açısından risklidir ve düzenli taranmalıdır.
- Gebelikte **yüksek tansiyon** olmuşsa kan basıncının normale dönüp dönmediği izlenir.

Aile planlaması bu izlemde netleştirilir:

- **Laktasyonel amenore yöntemi (LAM):** Üç koşul **birlikte** sağlanıyorsa koruyucudur: (1) bebek 6 aydan küçük, (2) bebek tam ya da tama yakın emziriliyor (gece dahil, emzirmeler arası uzun değil), (3) adet kanaması başlamamış. Koşullardan biri bozulduğunda başka bir yönteme geçilmelidir.
- **Emziren anne** için östrojen içermeyen yöntemler tercih edilir: kondom, bakırlı rahim içi araç (RİA), yalnız progestin içeren yöntemler (hap, iğne, implant).
- **Bakırlı RİA** doğumdan sonraki ilk 48 saat içinde ya da **4 haftadan sonra** takılabilir.
- **Kombine (östrojenli) haplar** süt miktarını azaltabileceğinden emziren annelere genellikle ilk 6 ayda önerilmez; emzirmeyen annede pıhtı riski nedeniyle doğumdan sonraki ilk 3 hafta (risk faktörü varsa 6 hafta) kullanılmaz.
- İki gebelik arasında en az 2 yıl bırakılmasının anne ve bebek sağlığı için önemi anlatılır.

Diğer konular: Cinsel yaşama, loşia bittikten ve perine iyileştikten sonra (genellikle 4–6 hafta) çiftin kendini hazır hissettiğinde dönülebileceği; emzirme döneminde vajinal kuruluk olabileceği; Td aşı takvimi eksikse tamamlanması; kanser taramalarına (yaş uygunsa HPV-smear) ileride katılımı; demir (3. ayın sonuna kadar) ve D vitamininin (6. ayın sonuna kadar) sürdürülmesi.

Bu izlemle lohusa izlemleri tamamlanır; kadın bundan sonra 15–49 yaş kadın izlemi, aile planlaması ve kanser tarama programları kapsamında izlenmeye devam eder.

3.6 Doğum sonu tehlike belirtileri (lohusaya öğretilecek liste)

Aşağıdakilerden biri olursa **beklemeden** hastaneye başvurmalıdır:

1. Ani artan kanama (bir saatte bir pedi tamamen ıslatacak kadar) ya da büyük pıhtılar
2. 38 °C ve üstü ateş, titreme
3. Kötü kokulu akıntı, şiddetli karın ağrısı
4. Şiddetli baş ağrısı, bulanık görme, havale
5. Nefes darlığı, göğüs ağrısı
6. Bacakta tek taraflı ağrı, şişlik, kızarıklık
7. Memede kızarık, sıcak, ağrılı sertlik ile birlikte ateş
8. Epizyotomi ya da sezaryen yarasında açılma, akıntı, artan ağrı
9. İdrar yaparken yanma, idrar yapamama
10. Kendine ya da bebeğine zarar verme düşünceleri, derin umutsuzluk

3.7 Örnek: "Doğum sonu 4. gündeki lohusa izlemini anlat"

> "Ev ziyaretinde ya da ASM'de anneyi ve bebeği birlikte karşılarım. Doğum kaydını incelerim: normal doğum mu sezaryen mi, epizyotomi var mı, kanama olmuş mu. Anneye ağrısını, kanamasını, ateşini, baş ağrısını, idrar ve dışkılamasını, uykusunu ve emzirmenin nasıl gittiğini sorarım. Ateşini, nabzını ve kan basıncını ölçerim. Memelerine bakarım: sütün gelmeye başladığı, memelerin dolgunlaştığı dönemdeyiz; meme başında çatlak var mı kontrol ederim. Mesanesini boşalttıktan sonra fundusa bakarım; göbeğin yaklaşık 4 parmak altında ve sert olmasını beklerim. Loşia rubradan serosaya geçiyor olmalı, kötü kokmamalı. Epizyotomiyi kızarıklık, şişlik, morarma, akıntı ve yara kenarları açısından değerlendiririm. Bacaklarında tek taraflı şişlik-ağrı var mı bakarım. Ruh halini sorarım; ağlamaklılık varsa lohusa hüznünün normal olduğunu ve iki haftada geçeceğini, geçmezse bize söylemesini anlatırım. Bir emzirmeyi baştan sona izler, tutuş ve kavramayı kontrol ederim; gerekirse düzeltirim. Perine hijyenini, sık emzirmeyi, mama vermemeyi, demir ve D vitaminine devam etmesini ve doğum sonu tehlike belirtilerini anlatırım. Kayıt eder, bir sonraki izlemin 13–17. günler arasında, bebeğin 15. gün izlemiyle birlikte olacağını söylerim."

4. YENİDOĞAN VE BEBEK İZLEMİ (0–1 YAŞ)

4.1 Genel bilgiler ve izlem takvimi

Her bebek ilk bir yaşında **en az 9 kez** izlenir. İzlemlerde bebeğin büyümesi ve gelişmesi değerlendirilir, aşıları yapılır, D vitamini ve demir desteği verilir, taramaların sonuçları takip edilir ve aileye o döneme özgü bakım bilgisi verilir. Doğumdaki ilk izlem hastanede yapılır; diğer 8 izlemden aile hekimliği birimi sorumludur.

- **1. izlem – Doğumda** (hastanede)
- **2. izlem – İlk hafta içinde** (yenidoğan izlemi; kaynaklarda 1.–10. gün aralığı olarak geçer, çoğunlukla 3.–5. günlerde ev ziyaretiyle yapılır)
- **3. izlem – 15. gün** (yaklaşık 2.–4. hafta)
- **4. izlem – 41. gün** (yaklaşık 30.–59. gün)
- **5. izlem – 2. ay**
- **6. izlem – 3. ay**
- **7. izlem – 4. ay**
- **8. izlem – 6. ay**
- **9. izlem – 9. ay**

Bunu ezberlemenin kolay yolu: **"Doğum – ilk hafta – 15 – 41 – sonra 2, 3, 4, 6, 9. aylar."**

4.2 Bebek izleminde ölçümler nasıl yapılır?

Ağırlık: Bebek, kalibre edilmiş bebek tartısında **çıplak** olarak (ya da kuru bir bezle; bezin ağırlığı düşülür) tartılır. Tartı her kullanımdan önce sıfırlanır. Mümkünse hep aynı tartı kullanılır. Bebek tartının üzerinde bir an bile yalnız bırakılmaz.

Boy: İki yaşından küçük bebeklerde boy **yatarak**, boy ölçme tahtası (infantometre) ile **iki kişiyle** ölçülür: bir kişi bebeğin başını sabit tahtaya dayar, diğer kişi dizleri hafifçe bastırarak bacakları düzleştirir ve ayak tabanlarını dik açıyla hareketli tahtaya dayar.

Baş çevresi: Esnemeyen bir mezura, önde **kaşların hemen üstünden**, arkada **başın arkasındaki en çıkıntılı noktadan (oksipital çıkıntı)** geçirilerek ölçülür. Bu şekilde başın en geniş çevresi bulunur; iki-üç ölçüm yapılıp en büyüğü alınır. Baş çevresi özellikle beyin büyümesini gösterir ve ilk iki-üç yılda her izlemde ölçülür.

Persentil eğrisine işleme: Her ölçüm yaşa ve cinsiyete uygun büyüme eğrisine işlenir. Tek bir ölçümden çok **eğrinin gidişi** önemlidir. Genel olarak 3. ile 97. persentil arası normal kabul edilir. Şu durumlarda hekime bildirilir: ölçümün 3. persentilin altında ya da 97. persentilin üstünde olması; bebeğin **iki ana persentil çizgisini aşağı ya da yukarı kesmesi** (ör. 50. persentilden 10. persentile düşmesi); kilo alımının durması; baş çevresinin çok hızlı büyümesi (hidrosefali şüphesi) ya da büyümemesi (mikrosefali).

Normal büyüme kuralları:

- Bebek ilk günlerde doğum ağırlığının **%7–10'unu** kaybedebilir ve **10–14. günde** doğum ağırlığına döner.
- İlk 3 ayda haftada yaklaşık **150–200 gram** alır.
- Doğum ağırlığı **4–5. ayda iki katına**, **1 yaşında üç katına** çıkar.
- Boy ilk yılda yaklaşık 25 cm uzar; **1 yaşında doğum boyunun 1,5 katına** (yaklaşık 75 cm) ulaşır.

- Baş çevresi doğumda 33–35 cm'dir; **ilk 3 ayda ayda yaklaşık 2 cm**, **4–6. aylarda ayda 1 cm**, **6–12. aylarda ayda 0,5 cm** büyür; 1 yaşında yaklaşık 45–47 cm olur.

4.3 Birinci izlem – Doğumda (hastanede)

Bu izlem doğumhane ve yenidoğan bakımını kapsar; ASM bu bilgileri ilk ev ziyaretinde kayıttan ya da aileden öğrenir.

- **Apgar skoru** doğumdan sonra **1. ve 5. dakikada** değerlendirilir. Beş ölçüt her biri 0–2 puan alır: kalp hızı, solunum çabası, kas tonusu, uyarıya tepki (refleks irritabilite) ve renk. **7–10 normal**, 4–6 orta derecede sıkıntı, 0–3 ağır sıkıntıdır.
- Bebek kurulanır, sıcak tutulur, anneyle **ten tene temasa** alınır ve **ilk 1 saat içinde emzirmeye** başlanır.
- **K vitamini** kas içine yapılır (yenidoğanda K vitamini eksikliğine bağlı kanamayı önler).
- **Hepatit B aşısının ilk dozu** yapılır (ilk 24 saat içinde, tercihen ilk saatlerde). Annesi Hepatit B taşıyıcısı olan bebeğe aşıyla birlikte, farklı bir bacağa Hepatit B immünglobulini de yapılır.
- Ağırlık, boy, baş çevresi ölçülür; baştan aşağı muayene edilir.
- Bebek **48 saati doldurup beslenmeye başladıktan sonra** (genellikle taburculuktan önce) **topuk kanı** alınır; **işitme taraması** yapılır.

4.4 İkinci izlem – İlk hafta içinde (yenidoğan izlemi)

Bu izlem ideal olarak **ev ziyareti** şeklinde, hastaneden çıktıktan sonraki ilk günlerde (genellikle 3.–5. günler) yapılır. Ev ziyareti, bebeğin yaşadığı ortamı (ısı, hijyen, sigara dumanı, uyku yeri) görme fırsatı verir. Bu izlem genellikle annenin birinci lohusa izlemiyle birlikte yapılır.

Öykü – neleri sorarım?

- **Doğum bilgileri:** Doğum tarihi ve saati, kaçıncı haftada doğduğu (37 haftadan önce doğanlar prematüredir ve daha yakın izlenir), doğum şekli, doğum ağırlığı-boyu-baş çevresi, Apgar puanı, hastanede yaşanan sorunlar (solunum sıkıntısı, sarılık tedavisi, yoğun bakım), taburculuk ağırlığı.
- **Hastanede yapılanlar:** K vitamini ve Hepatit B aşısı yapıldı mı? **Topuk kanı ne zaman alındı** (48. saatten önce alınmışsa tekrar gerekir)? **İşitme taraması** sonucu "geçti" mi "kaldı" mı?
- **Beslenme:** Yalnızca anne sütü mü alıyor? Günde kaç kez emiyor (8–12 kez beklenir)? Bir emzirme ne kadar sürüyor? Hastanede ya da evde mama, su, şekerli su verildi mi?
- **Islak bez ve dışkı:** Bebeğin yeterli süt alıp almadığının en iyi göstergelerinden biridir. Genel bir kural olarak bebek ilk gün en az 1, ikinci gün en az 2, üçüncü gün en az 3 bez ıslatır; **5.–6. günden itibaren günde en az 6 ıslak bez** beklenir. Dışkı ilk 1–2 gün koyu yeşil-siyah ve yapışkandır (**mekonyum**), 3.–4. günlerde yeşilimsi-kahverengi geçiş dışkısına, 5. günden sonra **sarı, yumuşak, taneli** anne sütü dışkısına dönüşür. Mekonyumun ilk 24–48 saatte çıkmış olması gerekir.
- **Uyku, ağlama, kusma:** Bebek nerede ve hangi pozisyonda uyutuluyor? Kusma var mı (az miktarda geri çıkarma normaldir; fışkırır tarzda, safralı/yeşil kusma anormaldir)?
- **Ailenin kaygıları** ve annenin durumu.

Muayene – baştan aşağı

- **Genel görünüm:** Bebek uyanıkken canlı mı, iyi emiyor mu, ağlaması güçlü mü? Uyuşukluk, zor uyanma, tiz ve sürekli ağlama anormaldir.
- **Vital bulgular: Solunum sayısı tam 1 dakika** sayılır; normal **30–60/dk**'dır, 60 ve üstü hızlı solunumdur. Göğüste çekilme, burun kanadı solunumu, inleme olmamalıdır. **Kalp tepe atımı 120–160/dk**, **koltuk altı ısısı 36,5–37,5 °C**'dir. Yenidoğanda hem ateş hem de ısının düşmesi (hipotermi) tehlikelidir.

- **Renk ve sarılık:** Bebek gün ışığında değerlendirilir; cilde parmakla hafifçe bastırılıp bırakıldığında sarı renk görülüyorsa sarılık vardır. Sarılık baştan başlayıp ayaklara doğru ilerler: yüzde sınırlı hafif sarılık daha az endişe vericidir; **göğsün altına, karna, kollara-bacaklara, avuç içi ve ayak tabanına yayılan** sarılık daha yüksek bilirubin düzeyini gösterir. **Fizyolojik sarılık** 2.–3. günde başlar, 7–10 günde azalır. **İlk 24 saatte başlayan**, hızla artan, avuç-tabana yayılan sarılık, **açık renkli (kil rengi/beyazımsı) dışkı ve koyu idrar** ile birlikte olan sarılık ya da sarılıklı bebeğin iyi ememesi **hemen hekime bildirilir.** Morarma (siyanoz) ve aşırı solukluk da anormaldir.
- **Baş: Ön fontanel** (bıngıldak) elmas şeklindedir, bebek sakin ve dik tutulduğunda **düz** olmalıdır. **Çökük fontanel susuzluğu (dehidratasyon)**, **kabarık-gergin fontanel kafa içi basınç artışını** (ör. menenjit) düşündürür. Arka fontanel küçüktür ve yaklaşık 2 ayda kapanır. Doğuma bağlı başta şişlik ya da kanama (kaput, sefal hematom) olup olmadığına bakılır.
- **Gözler:** Akıntı, kızarıklık, şişlik; ışık tutulduğunda iki gözde eşit **kırmızı yansıma (kırmızı refle)** görülmelidir. **Beyaz yansıma** (katarakt ya da göz tümörü olabilir) acil sevk nedenidir.
- **Ağız:** Damak yarığı, ağız içinde beyaz plaklar (pamukçuk), dil bağının emmeyi engelleyip engellemediği.
- **Boyun ve köprücük kemikleri:** Köprücük kemiğinde kırık doğumda olabilir; dokununca hışırtı ve Moro refleksinde o tarafın kolunun hareket etmemesi kırığı düşündürür.
- **Göğüs ve karın:** Solunum hareketleri, karında şişlik.
- **Göbek kordonu:** Kuruyor mu? Kızarıklık, kötü koku, akıntı, kanama var mı? Göbek çevresinde yayılan kızarıklık enfeksiyondur (omfalit) ve acildir.
- **Genital bölge ve anüs:** Erkek bebekte testislerin torbada olup olmadığı, idrar deliğinin yeri; kız bebekte birkaç gün görülebilen beyaz akıntı ya da az kanama (annenin hormonlarına bağlıdır, normaldir). Anüsün açık olduğu ve dışkı çıkardığı kontrol edilir.
- **Kalça:** Bebeğin bacakları dizlerden bükülüp yanlara açıldığında (abdüksiyon) bir tarafta kısıtlılık, uyluk ve kalça cilt kıvrımlarında asimetri, bacak boyları arasında fark gelişimsel kalça displazisi işaretidir. Kalça muayenesi (Ortolani ve Barlow manevraları) hekim ya da eğitimli sağlık personeli tarafından yapılır.
- **Omurga ve ekstremiteler:** Sırtın alt kısmında çukur, kıllanma, şişlik; parmak sayısı; kol ve bacak hareketlerinin simetrisi.
- **Cilt:** Burunda küçük beyaz noktalar (milia), sırt-kalçada mavi-gri lekeler (Moğol lekesi), kırmızı zeminde küçük sarı-beyaz kabarcıklar (eritema toksikum) normaldir. Peteşi (bastırınca solmayan noktasal kızarıklıklar), açıklanamayan morluklar anormaldir.
- **Refleksler: Arama** (yanağa dokununca o tarafa döner), **emme**, **yakalama** (avuca dokununca kavrar) ve **Moro** (ani ses ya da düşme hissinde kollarını açıp kapatır) refleksleri değerlendirilir. Refleksin hiç olmaması ya da iki tarafta farklı olması anormaldir.

Ölçümler

Ağırlık, boy ve baş çevresi ölçülür ve persentile işlenir. Doğum ağırlığına göre **kayıp yüzdesi** hesaplanır: (doğum ağırlığı – şimdiki ağırlık) / doğum ağırlığı × 100. Örneğin 3400 g doğan bebek 3150 g ise kayıp 250 g, yani yaklaşık %7,4'tür (kabul edilebilir). **%10'dan fazla kayıp** emzirmenin yetersiz olabileceğini gösterir; emzirme hemen değerlendirilir ve hekime bildirilir.

Bu izlemde yapılanlar

- **D vitamini** başlatılır: Doğumdan sonraki ilk günlerden itibaren **günde 400 IU (genellikle 3 damla)**, **1 yaşın sonuna kadar.** Damlanın doğrudan bebeğin ağzına ya da bir kaşık anne sütüyle verilmesi, şişeyi sallamak gerekiyorsa sallanması anlatılır.
- **Topuk kanı** alınmamışsa, 48. saatten önce alınmışsa ya da örnek uygun değilse yeniden alınması sağlanır. Sonuçların ASM tarafından takip edileceği söylenir.

- **İşitme taramasında "kaldı"** sonucu varsa tekrar test için yönlendirilir. İşitmede hedef: **1. ayda tarama, 3. ayda tanı, 6. ayda müdahale**.
- Hepatit B aşısı yapılmamışsa yapılır.

Bu izlemde anlatılacaklar

- **Emzirme:** Doğru tutuş ve kavrama gösterilir (lohusa bölümüne bakınız); bebeğin isteğine göre gece dahil sık emzirme; ilk 6 ay su dahil hiçbir şey verilmemesi; yeterli süt belirtileri (ıslak bez, dışkı, kilo).
- **Göbek bakımı:** Göbek temiz ve kuru tutulur; bez göbeğin altında kalacak şekilde katlanır; kirlenirse temiz suyla silinip iyice kurutulur; kurum aksini söylemedikçe alkol ya da antiseptik sürmek gerekmez; göbeğe bağ, para, toz vb. konmaz. Göbek **5–15 gün** içinde kendiliğinden düşer. Kızarıklık, koku, akıntı olursa başvurulmalıdır.
- **Banyo ve cilt bakımı:** Kısa süreli, ılık suyla (suyun ısısı dirsekle kontrol edilir), sıcak ve cereyansız bir odada; banyodan sonra iyice kurulama, özellikle kıvrım yerleri. Pişiği önlemek için bez sık değiştirilir, kalça bölgesi suyla temizlenip kurulanır, gerekirse bariyer krem sürülür.
- **Isı ve giydirme:** Oda ısısı yaklaşık 22–24 °C; bebek yetişkinden bir kat fazla giydirilir, aşırı sarıp sarmalanmaz. **Sıkı kundak yapılmaz** (kalça gelişimini bozar).
- **Güvenli uyku:** Bebek **sırtüstü** yatırılır; sert ve düz yatakta, yastık, yorgan, yumuşak oyuncak olmadan uyutulur; ilk aylarda anne-babayla aynı odada ama kendi yatağında uyur; evde sigara içilmez; bebek aşırı ısıtılmaz. Bunlar **ani bebek ölümü sendromunu** önler.
- **Sarılığı izleme:** Sarılığın artması, avuç-tabana yayılması, dışkının açık renk olması, bebeğin iyi ememesi durumunda hemen başvurulmalıdır.
- **Enfeksiyondan korunma:** Bebeğe dokunmadan önce el yıkama, hasta kişilerin bebekle temasını sınırlama, kalabalık ziyaretçiden kaçınma.
- **Bebeği asla sarsmama:** Uzun ağlamalarda bile bebek sarsılmaz (sarsılmış bebek sendromu beyin hasarına yol açar); anne-baba çok gerildiğinde bebeği güvenli bir yere yatırıp kısa bir mola vermelidir.
- **Tehlike belirtileri** (bu bölümün sonundaki liste).

Bir sonraki izlem

15. gün. Bu izlemde bebeğin doğum ağırlığına dönüp dönmediğine, göbeğin düşüp düşmediğine, sarılığın geçip geçmediğine ve topuk kanı sonucuna bakılacağı söylenir.

4.5 Üçüncü izlem – 15. gün

Odak noktaları

- **Ağırlık:** Bebek **doğum ağırlığına dönmüş olmalıdır.** Dönmemişse emzirme ayrıntılı değerlendirilir (sıklık, kavrama, gece emzirme, mama-su kullanımı), kısa aralıklarla tartı kontrolü planlanır ve hekime bildirilir.
- **Göbek:** Düşmüş olmalıdır. Düştükten sonra göbek çukurunda nemli, pembe, et benzeri küçük bir doku kalabilir (granülom) – hekime gösterilir.
- **Sarılık: Miadında doğan bebekte 2 haftadan uzun süren sarılık "uzamış sarılık"tır** ve hekim değerlendirmesi gerektirir. Özellikle **açık renkli dışkı ve koyu idrar** varsa safra yollarının tıkanıklığı (zaman kritik bir hastalık) düşünülerek **hemen** yönlendirilir. Anneye dışkı rengini her gün izlemesi öğretilir.
- **Tarama sonuçları:** Topuk kanı sonucu sisteme düştü mü, normal mi, tekrar örnek istendi mi? İşitme taraması "kaldı" ise tekrar test yapıldı mı? **Kalça ultrasonu** için randevu (genellikle **4.–6. haftalar** arasında) planlanır; risk faktörü olan bebeklerde (makat geliş, ailede kalça çıkığı) daha erken.
- **Göz:** Kırmızı refle tekrar değerlendirilir; göz yaşarması ve çapaklanma (gözyaşı kanalı tıkanıklığı) varsa iç köşeye masaj anlatılır, kızarıklık ve yoğun akıntı varsa hekime yönlendirilir.

Gelişim (2. hafta)

Yüze bakar, kısa süre göz teması kurar, ani seslere irkilir ya da sakinleşir, yüzüstü yatırıldığında başını kısa süre kaldırıp yana çevirir. Primitif refleksler devam eder.

Sık sorunlar ve anlatılacaklar

- **Bebek koliği:** Genellikle 2.–3. haftalarda başlar, 3.–4. ayda geçer. Bebek sağlıklı ve iyi kilo almasına rağmen genellikle akşamları, günde 3 saatten fazla, haftada 3 günden fazla ve 3 haftadan uzun süren ağlama nöbetleri geçirir. Kucakta dik tutma, ritmik sallanma, sakin ortam, karın üstü kucakta taşıma, emzirme sonrası gaz çıkarma önerilir. Ağlamayla beraber ateş, kusma, emmeme, kilo alamama varsa kolik değildir, hekime gidilmelidir.
- **Gaz çıkarma:** Emzirme sonrası bebeği omuza dik yaslayıp sırtını hafifçe sıvazlama.
- **Burun tıkanıklığı:** Serum fizyolojik damla ve ince bir bezle temizleme.
- **Geri çıkarma (regürjitasyon):** Az miktarda süt geri çıkarma, bebek kilo alıyorsa normaldir; fışkırır tarzda kusma, yeşil kusma, kilo alamama anormaldir.
- D vitaminine devam, güvenli uyku, sarsmama, annenin dinlenmesi.

Bir sonraki izlem

41. gün (yaklaşık 30.–59. gün arası). Kalça ultrasonunun bu arada yapılıp sonucuyla gelinmesi istenir.

4.6 Dördüncü izlem – 41. gün

Ölçümler

Bebek ilk aylarda **haftada 150–200 gram**, yani ayda yaklaşık 600–800 gram almalıdır; boy ayda yaklaşık 3–4 cm, baş çevresi ayda yaklaşık 2 cm artar. Ölçümler persentile işlenip önceki ölçümlerle karşılaştırılır.

Gelişim (6 hafta civarı)

- **Sosyal gülümseme** başlar (6.–8. haftalar) – bebek kendisine gülümseyen yüze gülümseyerek karşılık verir. Bu önemli bir gelişim basamağıdır.
- Hareket eden bir nesneyi ya da yüzü gözleriyle orta hatta kadar takip eder.
- Yüzüstü yatarken başını kısa süre kaldırır.
- Sese doğru döner; gırtlaktan sesler çıkarmaya ve **agulamaya** başlar.
- Eller çoğunlukla yumruk halindedir ama açılmaya başlar.

Bu izlemde yapılanlar

- **Kalça ultrasonu** sonucu değerlendirilir; anormalse ortopediye yönlendirildiği kontrol edilir.
- Topuk kanı ve işitme taraması sonuçlarının kesinleştiği doğrulanır.
- Kırmızı refle, fontaneller, kalça muayenesi tekrarlanır.
- **Aşı:** Güncel takvimde (altılı karma aşıya geçildikten sonra) bu dönemde rutin aşı yoktur; **2. ay aşıları bir sonraki izlemde** yapılacaktır. (Annesi Hepatit B taşıyıcısı olan bebeklerde ek doz hekim protokolüne göre 1. ayda yapılır. Eski takvimde 1. ay sonunda Hepatit B ikinci dozu vardı; 2025 öncesi doğan çocukların kartlarında bunu görebilirsin.)

Anlatılacaklar

- **Yüzüstü oyun zamanı:** Bebek uyanıkken ve gözetim altındayken günde birkaç kez kısa süreli yüzüstü yatırılır; boyun ve sırt kaslarını güçlendirir. Uykuda ise her zaman sırtüstü.
- **Gelişimi destekleme:** Bebekle göz göze konuşmak, gülümsemek, şarkı söylemek; bebeğin seslerine karşılık vermek.

- **Aşılar hakkında bilgi:** Bir sonraki izlemde BCG, altılı karma ve pnömokok aşılarının yapılacağı, aşıların neden önemli olduğu, aşı sonrası olabilecek durumlar.
- **Kaza önleme:** Bebek yakında dönmeye başlayacağı için alt değiştirme masası, yatak ve kanepede **asla yalnız bırakılmamalıdır.**
- Annenin aile planlaması ve üçüncü lohusa izlemi.

Bir sonraki izlem

2. ayın sonu (bebek 2 aylık olduğunda) – **aşı izlemi.**

4.7 Beşinci izlem – 2. ay (aşı izlemi)

Bu izlemde yapılacak aşılar

- **BCG (verem aşısı):** Canlı aşıdır; **deri içine (intradermal)**, üst kolda deltoid kasın alt ucuna denk gelen bölgeye, bir yaşından küçük bebeklerde **0,05 ml** yapılır. Doğru uygulandığında deride küçük bir kabarcık oluşur.
- **Altılı karma aşı (DaBT-İPA-Hib-HepB) 1. doz:** Difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci, Hemofilus influenza tip b ve Hepatit B'ye karşı korur. **Kas içine**, bebeğin **uyluğunun ön-dış yüzüne** (vastus lateralis kası) yapılır.
- **KPA (konjuge pnömokok aşısı) 1. doz:** Zatürre, menenjit ve kulak enfeksiyonlarına yol açan pnömokok bakterisine karşı korur. Kas içine, **diğer uyluğa** yapılır. (Aynı uyluğa iki aşı yapılacaksa aralarında en az 2,5 cm bırakılır.)

Aşı öncesinde sorulacaklar

- Bebeğin bugün hastalığı, ateşi, ishali, kusması var mı? (**Hafif hastalık, hafif ateş, hafif ishal aşıya engel değildir.** Orta-ağır hastalıkta aşı iyileşene kadar ertelenir.)
- Daha önceki aşıdan sonra ciddi bir tepki (alerjik reaksiyon, yüksek ateş, nöbet) oldu mu?
- Bilinen alerjisi var mı?
- Bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalığı ya da tedavisi var mı (BCG gibi canlı aşılar için önemli)?
- Son zamanlarda kan ya da kan ürünü aldı mı? Prematüre doğmak, emzirilmek, annenin yeniden gebe olması, ailede havale öyküsü, antibiyotik kullanıyor olmak aşıya engel **değildir**.

Aşı uygulaması ve sonrası

Bebek mümkünse **annesinin kucağında, emzirilirken ya da dik tutularak** aşılanır; bu ağrıyı azaltır. Enjeksiyonlar hızlı yapılır, aşılarda aspirasyon yapılmaz, en ağrılı aşı en sona bırakılır. Aşıdan sonra aile **en az 15 dakika** (risk varsa 30 dakika) ASM'de bekletilir; bu süre içinde nadir de olsa görülebilen ciddi alerjik reaksiyon (anafilaksi) açısından gözlenir.

Aileye şunlar anlatılır:

- Aşı yerinde kızarıklık, şişlik, ağrı ve 1–2 gün süren hafif ateş, huzursuzluk olabilir; aşı yerine soğuk uygulama yapılır, ovulmaz; ateş için hekimin önerdiği ilaç kullanılır.
- **BCG reaksiyonu:** 2–3 hafta sonra aşı yerinde küçük bir kızarıklık ve kabarıklık, ardından iltihaplı bir kabarcık ve küçük bir yara oluşur; 2–3 ay içinde iyileşip **küçük bir iz** bırakır. Bu normaldir ve aşının tuttuğunu gösterir. **Üzerine krem, pudra, antiseptik sürülmez, pansuman yapılmaz, sıkılmaz.** Koltuk altında büyük, akıntılı bir şişlik olursa hekime gösterilir.
- **Acil başvuru gerektiren durumlar:** 3 saatten uzun süren durdurulamayan ağlama, yüksek ateş, havale, bebeğin gevşek-tepkisiz olması, solunum sıkıntısı, yaygın döküntü.
- Aşı kartı saklanır; sonraki aşıların tarihleri yazılır.

Gelişim (2. ay)

Sosyal gülümseme belirgindir; agular; yüzüstü yatarken başını yaklaşık 45 derece kaldırır; sesleri ve yüzleri takip eder; elleri sık sık açıktır. Bu yaşta **sosyal gülümsemenin olmaması** dikkat gerektirir.

Ölçümler ve diğer

Ağırlık, boy, baş çevresi, persentil; kırmızı refle; kalça; D vitamini kullanımı; beslenme (yalnızca anne sütü).

Bir sonraki izlem

3. ay. Bu izlemde aşı yapılmayacağı, gelişimin değerlendirileceği söylenir.

4.8 Altıncı izlem – 3. ay

Gelişim (3. ay)

- **Baş kontrolü** gelişir: Bebek dik tutulduğunda başını dik ve sabit tutabilir; sırtüstü yatarken ellerinden tutulup oturur pozisyona çekildiğinde başı geride çok az kalır (4. ayda hiç kalmaz).
- Yüzüstü yatırıldığında **ön kollarına dayanarak** göğsünü ve başını kaldırır.
- Ellerini orta hatta birleştirir, ellerini izler, ağzına götürür.
- **Sesli güler**, ses çıkararak "konuşur", annesini tanır.
- Sesin geldiği yöne başını çevirir.
- Moro refleksi azalmaya başlar.

Değerlendirme ve anlatılacaklar

Ölçümler persentile işlenir; beslenme, uyku, D vitamini sorulur. Gelişimi destekleme: renkli ve sesli oyuncaklar (çıngırak), bebeğe kitap gösterme, konuşma, yüzüstü oyun zamanı. **Ek gıdaya 6. aydan önce başlanmaması** gerektiği vurgulanır (bazı aileler "bebek doymuyor" diye erken başlamak ister). Bebek dönmeye başlayacağı için düşme önlemleri hatırlatılır.

Bir sonraki izlem

4. ay – aşı izlemi.

4.9 Yedinci izlem – 4. ay

Bu izlemde yapılacak aşılar

- **Altılı karma aşı 2. doz** (kas içi, uyluk)
- **KPA 2. doz** (kas içi, diğer uyluk) Aşı öncesi sorgulama, uygulama ve aşı sonrası bilgilendirme 2. ay izlemindeki gibidir; ayrıca **önceki aşılardan sonra bir sorun olup olmadığı** sorulur.

Demir desteğinin başlatılması

Sağlık Bakanlığı programına göre miadında doğan bebeklere **4. ayın başından itibaren 12. ayın sonuna kadar** günde **1 mg/kg** demir verilir. Aileye: damlanın öğün aralarında verilmesi, **sütle birlikte verilmemesi**, dişlerde ve dişetlerinde koyu renk lekeler yapabileceği (damladan sonra bebeğe biraz su verilebilir ya da dişler temizlenir) ve dışkının koyulaşabileceği anlatılır. Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde demire daha erken ve daha yüksek dozda başlanır (hekim kararı). D vitamini de devam eder.

Gelişim (4. ay)

- Baş kontrolü tamdır.
- **Nesnelere uzanır**, avucuyla kavrar ve ağzına götürür.
- Yüzüstünden sırtüstüne dönmeye başlar (4.–5. ay).
- Kahkahayla güler, sesli oyun oynar.
- Yüzüstü yatarken kollarını düzleştirip göğsünü kaldırır.
- Ağırlığı doğum ağırlığının **iki katına** yaklaşır.

Dikkat: 4 aylık bebekte baş kontrolünün olmaması, nesneye hiç ilgi göstermemesi, bir elini hiç kullanmaması, göz temasının olmaması hekime bildirilir.

Anlatılacaklar

Demirin kullanımı; aşı sonrası bakım; ek gıdaya 6. ayda başlanacağı; salya artışı ve elini ağzına götürmenin normal olduğu (diş çıkarmaya hazırlık); bebek dönebildiği için yüksek yerlerde yalnız bırakılmaması; küçük nesnelerin bebeğin uzanabileceği yerlerden kaldırılması; bebek yürüteci kullanılmaması (kazalara yol açar, yürümeyi hızlandırmaz).

Bir sonraki izlem

6. ay – aşı ve ek gıda izlemi.

4.10 Sekizinci izlem – 6. ay

Bu izlemde yapılacak aşılar

- **Altılı karma aşı 3. doz** (kas içi, uyluk)
- **OPA (ağızdan çocuk felci aşısı) 1. doz:** Canlı aşıdır, **ağızdan 2 damla** verilir. Bebek aşıyı tükürür ya da birkaç dakika içinde kusarsa doz tekrarlanabilir.

Tamamlayıcı (ek) beslenmeye geçiş – ayrıntılı

6. aydan sonra anne sütü tek başına bebeğin enerji, demir ve diğer besin ihtiyaçlarını karşılamaz; bu nedenle anne sütüne **devam edilerek** ek besinlere başlanır.

- **Nasıl başlanır?** Günde 1–2 öğün, birkaç tatlı kaşığından 2–3 yemek kaşığına kadar, **ezilmiş/püre kıvamında** besinlerle başlanır. Besinler **kaşıkla** verilir; biberonla mama/çorba verilmez.
- **Hangi besinler?** Sebze püreleri (havuç, kabak, patates), meyve püreleri (elma, armut, muz), **demirden zengin besinler** (iyi pişmiş kırmızı et ve tavuk püresi, iyi pişmiş yumurta sarısı, mercimek gibi baklagiller), tahıllar (pirinç unu, bulgur, ezilmiş makarna), yoğurt.
- **Her yeni besin tek tek** ve 2–3 gün arayla denenir; böylece alerji ya da tahammülsüzlük olursa hangi besinden olduğu anlaşılır.
- Kıvam aylar içinde **giderek koyulaştırılır**: önce püre, sonra ezilmiş, sonra küçük yumuşak parçalar; 8–9. aydan sonra elle tutulan yiyecekler (parmak yiyecekleri). Uzun süre yalnızca sulu püre vermek çiğneme becerisinin gelişmesini geciktirir.
- **Öğün sayısı:** 6–8 ay arası günde 2–3 öğün, 9–11 ay arası 3–4 öğün ve 1–2 ara öğün; anne sütü her zaman devam eder.
- **Verilmeyecekler: Bal** (bir yaşından önce botulizm riski), **inek sütü içecek olarak** (bir yaşından önce demir eksikliğine yol açar; yoğurt ve yemeğe katılan az miktarda süt sorun değildir), **tuz ve şeker eklenmesi**, hazır meyve suları, çay (demir emilimini bozar), boğulma riski taşıyan bütün fındık-fıstık, bütün üzüm, sert çiğ sebze parçaları.
- 6. aydan sonra bebeğe **su** da verilebilir.

- Beslenme ortamı: Bebek dik oturtularak beslenir; yemek sırasında ekran olmaz; bebeğin açlık-tokluk işaretleri izlenir, zorla yedirilmez.

Gelişim (6. ay)

- Destekle, sonra kısa süre **desteksiz oturur** (6.–7. ay).
- **Nesneleri bir elinden diğerine aktarır.**
- Her iki yöne döner.
- **Heceler** çıkarır ("ba", "ma").
- Tanıdık yüzleri yabancılardan ayırt etmeye başlar; aynadaki görüntüsüne güler.
- Ayakta tutulduğunda bacaklarına yük verir.

Diş çıkarma

İlk süt dişleri genellikle **6.–8. aylarda alt orta kesiciler** olarak çıkar. Salya artışı, dişeti kaşıntısı, huzursuzluk, bir şeyleri ısırma isteği olabilir. **Yüksek ateş, ishal, döküntü diş çıkarmaya bağlanmamalıdır**; bunlar başka bir hastalığın belirtisi olabilir. İlk diş çıktığında yumuşak bir bebek diş fırçası ve **pirinç tanesi kadar** florürlü diş macunuyla günde iki kez temizlik önerilir; bebek biberonla ya da emerken uyutulup ağzında süt bekletilmemelidir.

Kaza önleme

Bebek artık her şeyi ağzına götürür ve hareketlidir: küçük nesneler, düğme pil, ilaç, deterjan ulaşamayacağı yere kaldırılır; sıcak içecekler bebek kucaktayken içilmez; masa örtüsü çekilip üstündekiler düşebilir; merdivenlere kapı konur.

Bir sonraki izlem

9. ay. Demir ve D vitaminine devam edileceği hatırlatılır.

4.11 Dokuzuncu izlem – 9. ay

Gelişim (9. ay)

- **Emekler**, **tutunarak ayağa kalkar**, mobilyalara tutunarak yan yan adım atmaya başlayabilir.
- Desteksiz ve dengeli oturur.
- Küçük nesneleri başparmağı ve diğer parmaklarıyla tutar (**kaba kıskaç**); 10–12. aylarda başparmak ve işaret parmağının uçlarıyla tutma (**ince kıskaç**) gelişir.
- "Ma-ma", "ba-ba", "da-da" gibi tekrarlayan heceler söyler (henüz anlamlı değildir).
- **Yabancılardan çekinir** (yabancı kaygısı), annesinden ayrılınca ağlar – bu normal bir gelişim basamağıdır.
- **"Ce-e" oyunu** oynar, el sallayarak "bay-bay" yapmayı öğrenir; saklanan bir nesneyi arar (nesnenin görünmese de var olduğunu anlar).
- Adına tepki verir.

Dikkat: 9 aylık bebeğin desteksiz oturamaması, hiç ses-hece çıkarmaması, adına tepki vermemesi, göz teması kurmaması, bacaklarına yük vermemesi hekime bildirilir.

Bu izlemde yapılanlar

- Ağırlık, boy, baş çevresi; persentil değerlendirmesi.
- **Kansızlık (anemi) taraması:** Kurum uygulamasına göre **9–12. aylar** arasında hemoglobin bakılır. Demir desteğini düzenli kullanıp kullanmadığı sorulur.
- Diş sayısı, diş temizliği.

- Kırmızı refle, şaşılık (bu yaştan sonra gözlerde kayma normal değildir), kalça, yürümeye hazırlık.
- Bu izlemde rutin aşı yoktur; **12. ay aşıları** hatırlatılır.

Beslenme

Günde 3–4 öğün ve 1–2 ara öğün; aile sofrasındaki yemeklerin **tuzsuz ve baharatsız** olarak ayrılıp ezilerek verilmesi; parmak yiyecekleri (haşlanmış sebze çubukları, yumuşak meyve dilimleri, ekmek); bardaktan su içmeye alıştırma; anne sütüne devam; bal, inek sütü (içecek olarak), şekerli-tuzlu hazır gıdalardan kaçınma.

Kaza önleme (en riskli dönemlerden biri)

- **Zehirlenme:** İlaçlar, temizlik malzemeleri, böcek ilaçları kilitli dolapta ve orijinal kaplarında saklanır. Zehirlenme şüphesinde kusturmaya çalışılmaz; **114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi** ya da **112** aranır.
- **Düşme:** Merdiven başlarına kapı, pencerelere kilit, balkonların güvenliği; mobilyalar devrilmeyecek şekilde duvara sabitlenir.
- **Boğulma (su):** Bebek küvette ya da su dolu bir kovanın yanında bir saniye bile yalnız bırakılmaz.
- **Yanık:** Sıcak sobalar, ütü, ocak, sıcak su; prizlere koruyucu.
- **Yabancı cisim:** Küçük oyuncak parçaları, bozuk para, fındık-fıstık.
- **Araç güvenliği:** Yaşa ve kiloya uygun, **arkaya bakan** bebek oto koltuğu.

Bir sonraki izlem

12. ay – çocuk izlemlerinin ilki. Bu izlemde **KKK (kızamık-kızamıkçık-kabakulak), suçiçeği ve pnömokok pekiştirme aşılarının** yapılacağı, D vitamini ve demirin bu izlemle sonlanacağı söylenir.

4.12 Bebeğin gelişimi – özet akış (ezber için)

- **1. ay:** Yüze bakar, yüzüstü başını kısa kaldırır, eller yumruk
- **2. ay: Sosyal gülümseme**, agulama, başını 45° kaldırır
- **3–4. ay: Baş kontrolü**, eller orta hatta, nesneye uzanma, sesli gülme
- **4–6. ay:** Dönme, avuçla kavrama, ağza götürme
- **6–7. ay: Desteksiz oturma**, **elden ele aktarma**, heceler
- **9. ay: Emekleme**, **tutunarak kalkma**, kaba kıskaç, "ma-ma/da-da", yabancı kaygısı, bay-bay
- **12. ay: İlk adımlar**/tutunarak yürüme, **ince kıskaç**, **1–2 anlamlı kelime**, basit komutları anlama

Primitif reflekslerin kaybolma zamanları: Arama ve emme 3–4 ay; avuç içi yakalama 3–4 ay; **Moro 4–6 ay**; asimetrik tonik boyun refleksi 4–6 ay; adım atma refleksi 2 ay; ayak tabanı yakalama 9–12 ay; **Babinski 12–24 ay.** Refleksin zamanında kaybolmaması da, hiç olmaması ya da iki tarafta farklı olması da anormaldir.

4.13 Gelişimde uyarı işaretleri (hekime bildirilecek)

- Herhangi bir yaşta **önceden kazanılmış bir becerinin kaybolması**
- 2 ayda sosyal gülümseme yok
- 4 ayda baş kontrolü yok, nesnelere uzanmıyor
- 6 ayda dönmüyor, ses çıkarmıyor
- 9 ayda desteksiz oturamıyor, adına tepki vermiyor
- 12 ayda işaret etmiyor, el sallamıyor, tutunarak ayağa kalkmıyor
- Bir yaşından önce belirgin el tercihi (diğer tarafta güçsüzlük olabilir)
- Göz teması kurmama, seslere tepkisizlik
- Gözlerde kayma (6 aydan sonra), beyaz göz bebeği yansıması

4.14 Bebekte tehlike belirtileri (aileye her izlemde öğretilecek)

Aşağıdakilerden biri varsa **beklemeden** sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır:

1. Ememiyor ya da hiçbir şey içemiyor
2. Her şeyi kusuyor; yeşil (safralı) kusma
3. Havale geçiriyor
4. Uyuşuk, uyandırmakta güçlük çekiliyor, bilinci bulanık
5. **Hızlı soluk alıyor** (2 aydan küçükte dakikada 60 ve üstü, 2–12 ayda 50 ve üstü), göğsü içe çekiliyor, inliyor, morarıyor
6. **3 aydan küçük bebekte 38 °C ve üstü ateş** ya da vücut ısısının düşmesi
7. İlk 24 saatte başlayan, avuç içi ve ayak tabanına yayılan sarılık; açık renkli dışkı
8. Göbek çevresinde yayılan kızarıklık, kötü koku, akıntı
9. Kanlı ishal, çok sayıda sulu dışkı, ağlarken gözyaşı olmaması, ıslak bez sayısının azalması, çökük bıngıldak (susuzluk)
10. Kabarık bıngıldak, ense sertliği, bastırınca solmayan döküntü

4.15 Örnek: "6 aylık bebek izlemini anlat"

> "Bebeğin kaydını incelerim: 2. ve 4. ay aşıları yapılmış mı, son kilo-boy-baş çevresi değerleri neymiş, demire 4. ayda başlanmış mı. Anne ve bebeği karşılar, kendimi tanıtıp izin alırım, ellerimi yıkarım. Anneye bebeğin genel durumunu, beslenmesini, ıslak bez ve dışkı durumunu, uykusunu, D vitamini ve demiri düzenli verip vermediğini, 4. ay aşılarından sonra bir sorun olup olmadığını ve endişelerini sorarım. Bebeği soyup baştan aşağı muayene ederim: bıngıldak düz mü, kırmızı refle eşit mi, gözlerde kayma var mı, diş çıkmış mı, kalçada kısıtlılık var mı, ciltte morluk ya da döküntü var mı. Ağırlık, boy ve baş çevresini ölçüp persentile işlerim; doğum ağırlığının iki katını geçmiş olmasını beklerim. Gelişimde desteksiz oturmaya başlayıp başlamadığına, nesneyi elden ele aktarıp aktarmadığına, iki yöne dönüp dönmediğine, hece çıkarıp çıkarmadığına bakarım. Aşıya engel bir durum olup olmadığını sorgular, altılı karma aşının 3. dozunu uyluğa kas içine yapar, OPA'yı ağızdan iki damla veririm; 15–30 dakika gözlerim. Anneye ek gıdaya nasıl başlayacağını ayrıntılı anlatırım: anne sütüne devam ederek, günde 1–2 öğünle, püre kıvamında, her yeni besini tek tek deneyerek, demirden zengin besinlerle; bal, inek sütü, tuz ve şeker vermeden. Diş temizliğini, kaza önlemlerini ve aşı sonrası bakımı anlatırım; demir ve D vitaminine devam etmesini söylerim. Kaydeder, bir sonraki izlemin 9. ayda olduğunu, o izlemde emekleme ve tutunarak kalkmaya bakacağımızı, kansızlık için kan tahlili isteyebileceğimizi söylerim."

5. ÇOCUK İZLEMİ (1–6 YAŞ)

5.1 Genel bilgiler ve izlem takvimi

Bir yaşından sonra çocuk izlemleri seyrekleşir ama içerikleri genişler: büyüme ve beslenmenin yanında **dil gelişimi, davranış, tuvalet eğitimi, görme, diş sağlığı, kan basıncı ve kaza önleme** öne çıkar. 1–6 yaş arasında **7 izlem** yapılır; böylece bir çocuk 6 yaşına kadar toplam **16 kez** izlenmiş olur.

- **12. ay**
- **18. ay**
- **24. ay**
- **30. ay**
- **36. ay (3 yaş)**
- **48. ay (4 yaş)**
- **60. ay (5 yaş)**

Ölçümlerde değişiklik: İki yaşından sonra boy **ayakta** ölçülür: çocuk ayakkabısız, topukları, kalçası, kürek kemikleri ve başının arkası duvara/boy ölçere değecek şekilde dik durur, başı düz bakar; ölçüm başlığı başın tepesine indirilir. İki yaşından sonra **beden kitle indeksi (BKİ)** hesaplanır ve yaşa-cinsiyete göre persentili değerlendirilir: **85. persentil ve üstü fazla kilolu, 95. persentil ve üstü obez**, 5. persentilin altı zayıftır. Baş çevresi ilk 2–3 yıl ölçülmeye devam eder.

5.2 12. ay izlemi

Aşılar

- **KPA (pnömokok) pekiştirme dozu** – kas içi
- **KKK (kızamık-kızamıkçık-kabakulak) 1. doz** – canlı aşı, deri altı (ürüne göre kas içi)
- **Suçiçeği aşısı** – canlı aşı, deri altı Canlı aşılar (KKK ve suçiçeği) **aynı gün** yapılır; aynı gün yapılamazsa aralarında **en az 4 hafta** olmalıdır. Aileye **KKK'dan 7–12 gün sonra** ateş ve hafif döküntü, suçiçeği aşısından sonra birkaç küçük kabarcık görülebileceği; bunun bulaşıcı olmadığı ve geçeceği anlatılır.

Büyüme

Ağırlık doğum ağırlığının **yaklaşık üç katına**, boy yaklaşık **75 cm**'ye, baş çevresi yaklaşık 45–47 cm'ye ulaşmıştır. Bir yaşından sonra büyüme hızı yavaşlar ve çocuğun iştahı azalır; aileye bunun normal olduğu anlatılır.

Gelişim (12. ay)

- Mobilyalara tutunarak yürür, **ilk bağımsız adımlarını** atabilir (bağımsız yürüme 12–15. aylar arasında, en geç 18. ayda gelişir).
- Başparmak ve işaret parmağının uçlarıyla küçük nesneleri tutar (**ince kıskaç**).
- **1–2 anlamlı kelime** söyler ("anne", "baba", "mama").
- "Gel", "ver" gibi **basit komutları** anlar.
- İstediği şeyi **parmağıyla gösterir**, el sallar, alkış yapar.
- Bardaktan içmeye çalışır.

D vitamini ve demirin sonlandırılması

D vitamini ve **demir** desteği **1 yaşın sonunda** sonlandırılır (risk durumunda hekim devam kararı verebilir). Kansızlık taraması 9. ayda yapılmadıysa yapılır.

Beslenme

- Bir yaşından sonra çocuk **aile sofrasına** katılır; yemekler az tuzlu, az baharatlı hazırlanır.
- **İnek sütü** içecek olarak verilebilir; ancak günde yaklaşık 2 su bardağını (yaklaşık 500 ml) geçmemelidir, fazlası iştahı kapatır ve demir eksikliğine yol açar.
- **Anne sütüne 2 yaş ve sonrasına kadar** devam edilmesi önerilir.
- Biberonu bırakıp bardaktan içmeye geçiş; şekerli içecek, hazır meyve suyu, cips, şekerleme gibi gıdalardan uzak durma.

Anlatılacaklar

- **Diş sağlığı:** Günde iki kez, pirinç tanesi kadar florürlü macunla diş fırçalama (ebeveyn yapar); gece biberonla uyutmama; **ilk diş hekimi kontrolü** (ilk dişle birlikte ya da 1 yaş civarında).
- **Kaza önleme:** Çocuk yürümeye başladığı için düşme, zehirlenme, yanık, suda boğulma, elektrik çarpması riskleri artar (bebek izlemindeki önlemler sürdürülür; masa köşelerine koruyucu, sıcak sıvılar ve ocak kolları çocuğun ulaşamayacağı yerde).
- **Ekran:** İki yaşından önce ekran önerilmez (görüntülü aile görüşmeleri hariç).
- **Gelişimi destekleme:** Resimli kitap okuma, nesnelerin adını söyleme, birlikte oyun.

Bir sonraki izlem

18. ay – karma aşı pekiştirmesi, OPA ve Hepatit A aşıları.

5.3 18. ay izlemi

Aşılar

- **Karma aşı pekiştirme dozu** (DaBT-İPA-Hib; kaynaklarda altılı karma olarak geçiyor – ASM'nin kullandığı ürünü kontrol et) – kas içi
- **OPA 2. doz** – ağızdan 2 damla
- **Hepatit A 1. doz** – kas içi

Gelişim (18. ay)

- **Bağımsız yürür**, koşmaya çalışır, tutunarak merdiven çıkar, oyuncak çekerek yürür.
- **3–4 küpü üst üste koyar**, kalemle karalar, kaşık kullanır.
- Yaklaşık **10–20 kelime** söyler; sorulduğunda vücut parçalarını gösterir; basit komutları yerine getirir.
- Ev işlerini taklit eder; yanındaki çocukla aynı ortamda ama ayrı oynar (paralel oyun).

Otizm açısından dikkat: 18–24. aylar otizm spektrum bozukluğunun fark edilmesi için önemli bir dönemdir. Şu bulgular sorulur ve gözlenir: göz teması kuruyor mu, adı söylenince dönüyor mu, ilgisini çeken bir şeyi parmağıyla gösterip anne-babasıyla paylaşıyor mu (ortak dikkat), taklit yapıyor mu, "-mış gibi" oyun oynuyor mu, kazandığı kelimeleri kaybetti mi, tekrarlayan hareketleri var mı? Şüphe varsa tarama ölçekleri (örneğin M-CHAT) kullanılır ve hekim aracılığıyla çocuk psikiyatrisine yönlendirilir.

Dikkat: 18 ayda yürümemesi, hiç kelime söylememesi, işaret etmemesi, kazandığı becerileri kaybetmesi hekime bildirilir.

Anlatılacaklar

- **Beslenme:** Bu yaşta seçici yeme ve iştahsızlık sıktır. Düzenli öğün saatleri, aileyle birlikte yemek, çocuğun kendi kendine yemesine izin verme, zorlamama, ödül ya da ceza olarak yiyecek kullanmama, ekran karşısında yedirmeme önerilir.

- **Uyku düzeni:** Düzenli yatış saati, yatmadan önce sakin rutin (banyo, kitap).
- **Diş fırçalama**, şekerli yiyecekleri sınırlama.
- **Kaza önleme:** Zehirlenme (ilaçlar, deterjanlar), düşme, yanık, araç koltuğu.
- **Ekran:** İki yaşından önce önerilmez.

Bir sonraki izlem

24. ay – Hepatit A ikinci doz.

5.4 24. ay izlemi

Aşılar

- **Hepatit A 2. doz** – kas içi

Gelişim (2 yaş)

- **Koşar**, topa vurur, merdiveni tutunarak ve her basamağa iki ayağını koyarak çıkar.
- **6 küplük kule** yapar, kitabın sayfalarını tek tek çevirir.
- **İki kelimelik cümleler** kurar ("anne su", "baba gitti"), yaklaşık 50 ve üzeri kelime bilir; "ben, benim" der.
- Taklit oyunları oynar (bebeğini besler, telefonla konuşuyormuş gibi yapar).
- Öfke nöbetleri sık görülür; özerklik kazanmaya çalışmanın normal bir parçasıdır.

Dikkat: 24 ayda **iki kelimelik anlamlı cümle kurmaması**, yürümede belirgin bozukluk, göz teması kurmama, sözel olmayan iletişimin de zayıf olması → hekime ve gerekirse işitme değerlendirmesine.

Tuvalet eğitimi

Tuvalet eğitimi için takvim yaşı değil **çocuğun hazır olması** belirleyicidir; çoğu çocuk **18–24. aydan sonra** hazır hale gelir. Hazır olma belirtileri: bezinin en az 2 saat kuru kalması, bezini kirlettiğini fark edip söylemesi ya da göstermesi, tuvalete ilgi duyması, basit komutları anlaması, altını indirip çıkarabilmesi, oturabilmesi. Eğitim **zorlamadan, cezalandırmadan, övgüyle** yapılır; çocuk lazımlığa düzenli aralıklarla (yemeklerden sonra, uykudan kalkınca) oturtulur. Kardeş doğumu, taşınma gibi stresli dönemlerde başlanmaz. Gündüz kuruluk genellikle 2–3 yaşta, gece kuruluk 4–5 yaşta kazanılır.

Anlatılacaklar

- **Ekran:** 2–5 yaş arasında günde **en fazla 1 saat**, çocuğa uygun içerikte ve ebeveynle birlikte; yemek ve uyku öncesinde ekran yok; yatak odasında ekran yok.
- **Öfke nöbetleriyle baş etme:** Sakin kalma, güvenliği sağlama, nöbet geçince sarılma; nöbetle istediğini alamayacağını tutarlı biçimde gösterme; olumlu davranışları övme.
- **Diş:** Günde iki kez fırçalama; 6 ayda bir diş hekimi kontrolü.
- **Beslenme ve fiziksel aktivite:** Her gün açık havada hareketli oyun.

Bir sonraki izlem

30. ay.

5.5 30. ay izlemi

Bu izlemde aşı yoktur. Odak **dil gelişimi, davranış, tuvalet eğitimi ve büyüme**dir.

Gelişim (2,5 yaş)

- 2–3 kelimelik cümleler kurar, sorulduğunda adını söyler, "ne?", "nerede?" sorularını sorar.
- Zıplar, tek ayak üstünde çok kısa durmaya çalışır, merdiveni daha rahat çıkar.
- Kalemi daha iyi tutar, düz çizgi çizer.
- Giyinmeye yardım eder, basit kıyafetleri çıkarır.
- Akranlarıyla oyuna ilgi duymaya başlar.

Değerlendirilenler ve anlatılacaklar

Büyüme ve BKİ persentili (fazla kilo bu yaşlarda belirginleşmeye başlar); tuvalet eğitiminin gidişi; uyku; davranış sorunları (aşırı hareketlilik, saldırganlık); **kardeş kıskançlığı** (yeni kardeş varsa); ekran süresi; diş sağlığı; kaza önleme (balkon, pencere, havuz, sokak). Konuşması yabancılar tarafından hiç anlaşılmıyor ya da çok az kelimesi varsa işitme ve dil değerlendirmesi için yönlendirilir.

Bir sonraki izlem

36. ay (3 yaş) – kan basıncı ölçümü ve görme değerlendirmesi başlayacak.

5.6 36. ay (3 yaş) izlemi

Bu izlemde aşı yoktur. İki yeni rutin başlar: **kan basıncı ölçümü** ve **görme taraması.**

Kan basıncı

Üç yaşından itibaren her yıl kan basıncı ölçülür. Çocuğun kol çevresine uygun **çocuk manşonu** kullanılır (dar manşon değeri yüksek gösterir). Sonuç yaş, cinsiyet ve boy persentiline göre değerlendirilir; yüksekse hekime bildirilir.

Görme

3–5 yaş arası **tembel göz (ambliyopi)** ve **şaşılık** açısından değerlendirme yapılır. Çocuk çok küçükse gözlem ve basit testler kullanılır: ışık tutulduğunda yansımanın iki gözde aynı noktada olup olmadığı (Hirschberg testi), bir göz kapatılıp açıldığında diğer gözde kayma hareketi olup olmadığı (kapama testi), yaşa uygun resimli görme eşelleri. Gözünü kısma, başını eğerek bakma, televizyona çok yakın oturma, sık göz ovma da sorulur. Tembel göz erken yaşta tedavi edilirse düzelebilir; geç kalınırsa kalıcı olabilir. Şüphede göz hekimine yönlendirilir.

Gelişim (3 yaş)

- **Üç tekerlekli bisiklet** sürer, merdiveni **ayak değiştirerek** çıkar, koşar, zıplar.
- **Daire çizer**, küplerle köprü yapar.
- **3–4 kelimelik cümleler** kurar; konuşmasının çoğunu yabancılar da anlar; adını, yaşını ve cinsiyetini söyler.
- Arkadaşlarıyla oynamaya başlar, sırasını bekleyebilir, paylaşmayı öğrenir.
- Gündüz tuvalet kontrolü büyük ölçüde kazanılmıştır.

Anlatılacaklar

Okul öncesi eğitim (kreş, anaokulu) olanakları; sağlıklı beslenme ve obeziteyi önleme (her gün sebze-meyve, şekerli içecek yerine su, düzenli öğün, ailecek yemek); günlük fiziksel aktivite (bu yaşta gün boyunca toplam en az 3 saat hareketli oyun önerilir); ekran sınırı; diş hekimi kontrolü; **kişisel güvenlik** ("vücudum bana ait", yabancılarla gitmeme – yaşa uygun dille); kaza önleme (yaya güvenliği, araçta çocuk koltuğu, suda güvenlik).

Bir sonraki izlem

48. ay (4 yaş) – KKK ikinci doz ve dörtlü karma aşı.

5.7 48. ay (4 yaş) izlemi

Aşılar

- **KKK 2. doz** – deri altı
- **DaBT-İPA (dörtlü karma) pekiştirme** – kas içi Eskiden ilkokul birinci sınıfta yapılan bu aşılar artık 48. ayda yapılmaktadır. Okula başlamadan önce aşı kartının tam olması önemlidir.

Değerlendirilenler

Ağırlık, boy, BKİ persentili; **kan basıncı**; **görme** (yaşa uygun eşelle her göz ayrı ayrı); **işitme** (konuşma anlaşılırlığı, seslere tepki, sık kulak enfeksiyonu öyküsü); diş (çürük); davranış ve okul öncesi uyum.

Gelişim (4 yaş)

- **Tek ayak üstünde sıçrar**, topu yakalar, merdiveni ayak değiştirerek iner.
- **Artı (+) işareti çizer**, makasla kesmeye başlar, 2–4 parçalı insan resmi çizer.
- **Hikâye anlatır**, renkleri söyler, "neden?" sorularını çok sorar, konuşması tamamen anlaşılır.
- Arkadaşlarıyla **işbirliği içinde** oynar, kurallı basit oyunlara katılır.
- Kendi kendine giyinir, elini yıkar, tuvaletini büyük ölçüde kendisi yapar.
- Gece kuruluğu genellikle 4–5 yaşında kazanılır; **5 yaşından sonra** devam eden gece ıslatması (enürezis) hekim değerlendirmesi gerektirir.

Anlatılacaklar

El yıkama alışkanlığı (çocuk 20 saniye el yıkamayı öğrenebilir); diş fırçalamada **bezelye tanesi kadar** florürlü macun; sağlıklı beslenme; ekran sınırı (günde en fazla 1 saat); kişisel güvenlik ve istismardan korunma (iyi ve kötü dokunma, sır tutmama, güvendiği bir yetişkine anlatma); trafik ve suda güvenlik; bisiklet kullanırken kask.

Bir sonraki izlem

60. ay (5 yaş) – okula hazırlık izlemi.

5.8 60. ay (5 yaş) izlemi – okula hazırlık

Bu izlemde aşı yoktur (48. ay aşılarının yapılmış olduğu kontrol edilir). Odak **okula hazır olma**dır.

Değerlendirilenler

- Büyüme ve BKİ; kan basıncı.
- **Görme ve işitme**: okul başarısını doğrudan etkiler; şüphede göz/KBB hekimine.
- **Diş:** Altı yaş civarında süt dişlerinin arkasında ilk **daimi azı dişleri** çıkar; aile bunların süt dişi sanılıp ihmal edilmemesi konusunda uyarılır; diş hekiminde **fissür örtücü** uygulaması önerilir.
- **Gelişim ve okula hazırlık:** Ayak değiştirerek sekme, ip atlamaya başlama; **üçgen çizme**, adını yazmaya çalışma; akıcı konuşma, basit sayma; kurallı oyunlara katılma, sıra bekleme, kısa süre dikkatini sürdürebilme; tuvalet ve giyinmede bağımsızlık; ebeveynden ayrılabilme.
- Dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, konuşma bozukluğu, öğrenme güçlüğü belirtileri varsa okul öncesi değerlendirme için yönlendirilir.

Anlatılacaklar

Okul öncesinde düzenli uyku (5 yaşta yaklaşık 10–13 saat), sağlıklı kahvaltı ve beslenme çantası; günde en az 60 dakika orta-şiddetli fiziksel aktivite; ekran süresinin sınırlanması; trafik güvenliği (okula gidiş-geliş, yaya geçidi, okul servisi); kişisel güvenlik; diş fırçalama; el hijyeni.

Bir sonraki izlem

Bundan sonra çocuk **okul çağı izlemine** geçer ve **yılda bir kez** izlenir.

6. OKUL ÇAĞI VE ERGEN İZLEMİ (6–19 YAŞ)

6.1 Okul çağı (6–9 yaş) – yılda bir izlem

Okul çağında çocuk her yıl izlenir. Bu izlemler hem ASM'de hem de okul sağlığı çalışmalarında (taramalar) yapılır.

Her yıl değerlendirilenler:

- **Boy, kilo, BKİ persentili:** Okul çağında obezite hızla artar; fazla kilolu ve obez çocuk beslenme ve fiziksel aktivite açısından ailesiyle birlikte değerlendirilir.
- **Kan basıncı** (yaş-cinsiyet-boy persentiline göre).
- **Görme:** Snellen ya da E eşeli ile, iyi aydınlatılmış ortamda, genellikle 6 metre mesafeden, her göz ayrı ayrı (önce sağ, sonra sol; diğer göz bastırmadan kapatılır), gözlüklüyse gözlükle. Görme keskinliği yaşa göre beklenenin altındaysa ya da iki göz arasında belirgin fark varsa göz hekimine.
- **İşitme:** Derste anlamakta güçlük, sesleri tekrar ettirme, televizyonu yüksek sesle izleme sorulur; gerekirse fısıltı testi ya da odyometri.
- **Diş:** Çürük, dolgu ihtiyacı, diş fırçalama alışkanlığı; 6 ayda bir diş hekimi.
- **Postür:** Çanta ağırlığı (vücut ağırlığının yaklaşık %10–15'ini geçmemeli, iki askılı ve iki omuzda taşınmalı), oturuş.
- **Okul uyumu ve başarısı, dikkat, arkadaş ilişkileri, akran zorbalığı.**
- **Uyku** (6–12 yaş için 9–12 saat), **ekran süresi**, fiziksel aktivite (günde en az 60 dakika).
- **İhmal ve istismar belirtileri** (aşağıda).

Anlatılacaklar: Kahvaltının önemi; beslenme çantasına sağlıklı yiyecekler; şekerli ve gazlı içecekler yerine su; el yıkama; diş fırçalama; bisiklette kask, trafik güvenliği; internet güvenliği; kişisel güvenlik; düzenli uyku.

6.2 Ergen izlemi (10–19 yaş) – yılda bir izlem

Ergenlik, fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan hızlı değişimlerin olduğu bir dönemdir. Ergen izleminde fizik muayene kadar **psikososyal değerlendirme** de önemlidir; ergenlerde ölüm ve sakatlık nedenlerinin büyük kısmı kazalar, şiddet, madde kullanımı ve intihar gibi davranışla ilgili nedenlerdir.

Ergenle görüşmenin ilkeleri

- Görüşmenin bir bölümü ebeveyn yanındayken, bir bölümü **ergenle yalnız** yapılır.
- Görüşmenin başında **gizlilik** açıklanır: "Burada konuştuklarımız aramızda kalır; ancak senin ya da bir başkasının hayatı tehlikedeyse, sana zarar veriliyorsa bunu yetkililerle paylaşmam gerekir."
- Yargılayıcı olmayan, öğüt vermeyen, saygılı bir dil kullanılır; ergenin kendi kararlarını vermesi desteklenir.
- Sorular genel ve az hassas konulardan (ev, okul) başlayıp daha hassas konulara (madde, cinsellik, ruh hali) doğru ilerler.

Psikososyal değerlendirme (HEEADSSS çerçevesi)

- **Ev:** Kiminle yaşıyor, ailesiyle ilişkisi nasıl, evde şiddet ya da ciddi bir sorun var mı?
- **Eğitim/iş:** Okul başarısı, devamsızlık, okulda kendini nasıl hissettiği, zorbalığa uğrayıp uğramadığı, gelecek planları.
- **Beslenme:** Öğün düzeni, kahvaltı, kilosu ve beden görüntüsüyle ilgili düşünceleri, kilo vermek için kusma, aç kalma, ilaç kullanma (yeme bozukluğu belirtileri).
- **Aktiviteler:** Boş zaman uğraşları, spor, arkadaşlar, günlük ekran süresi, sosyal medya kullanımı.
- **Madde:** Arkadaş çevresinde ve kendisinde sigara, elektronik sigara, alkol, madde kullanımı.

- **Cinsellik:** Ergenlik değişiklikleri hakkında soruları, (yaşa uygun biçimde) cinsel sağlık bilgisi, istismara maruz kalıp kalmadığı.
- **Duygu durumu, intihar:** Son zamanlarda sürekli üzgün, umutsuz, değersiz hissetme; ilgi kaybı; uyku ve iştah değişikliği; kendine zarar verme ya da intihar düşüncesi. **İntihar düşüncesi ifade eden ergen yalnız bırakılmaz ve hemen hekime yönlendirilir.**
- **Güvenlik:** Emniyet kemeri, kask kullanımı, internette tanımadığı kişilerle görüşme, şiddete maruz kalma, silah.

Fiziksel değerlendirme

- **Boy, kilo, BKİ:** Ergenlikte hızlı büyüme atağı olur (kızlarda daha erken). Hem obezite hem aşırı zayıflık (yeme bozukluğu) değerlendirilir.
- **Ergenlik gelişimi:** Ergenlik bulguları **Tanner evreleriyle** (1–5) değerlendirilir. Kızlarda ilk bulgu **meme tomurcuklanması**dır (ortalama 10–11 yaş), **ilk adet (menarş)** ortalama **12–13 yaşında** görülür. Erkeklerde ilk bulgu **testislerin büyümesi**dir (ortalama 11–12 yaş). **Erken ergenlik:** kızlarda **8 yaşından**, erkeklerde **9 yaşından** önce ergenlik bulgularının başlaması. **Gecikmiş ergenlik:** kızlarda **13 yaşına**, erkeklerde **14 yaşına** kadar hiçbir bulgunun olmaması. Her ikisi de hekime yönlendirilir.
- **Adet öyküsü (kızlarda):** Adet düzeni, ağrılı adet, çok kanama (kansızlık riski); ped kullanımı ve hijyen.
- **Skolyoz taraması:** Özellikle ergenliğin başında (kızlarda 10–12, erkeklerde 13–14 yaş) **Adams öne eğilme testi** yapılır: ergen ayakları bitişik, dizleri düz, kolları sarkık öne eğilir; arkadan bakılınca sırtta bir tarafta kabarıklık (kaburga kamburluğu), omuz ve kalça seviyelerinde fark, kürek kemiklerinde asimetri skolyozu düşündürür.
- **Kan basıncı, görme, diş, cilt (akne).**

Aşı

13 yaşında Td aşısı yapılır (genellikle 8. sınıfta okulda).

Anlatılacaklar

Sağlıklı beslenme ve kahvaltı; demirden zengin besinler (özellikle adet gören kızlar); günde en az 60 dakika fiziksel aktivite; uyku (13–18 yaş için 8–10 saat); ekran ve sosyal medya kullanımının sınırlanması, yatmadan önce telefonun bırakılması; sigara-elektronik sigara-alkol-madde kullanımının zararları ve akran baskısına "hayır" diyebilme; kişisel hijyen ve akne bakımı; adet hijyeni; ergenlik değişikliklerinin normal olduğu; trafik güvenliği; siber zorbalık ve internet güvenliği; sorun yaşadığında başvurabileceği kişi ve yerler (aile, rehber öğretmen, ASM).

6.3 Tüm çocukluk izlemlerinde: ihmal ve istismar belirtileri

Her izlemde akılda tutulmalıdır:

- Açıklanamayan ya da anlatılan öyküyle uyuşmayan morluklar, yanıklar, kırıklar; özellikle **henüz yürümeyen bebekte morluk**; kulak, boyun, gövde, kalça gibi düşmeyle zor yaralanan bölgelerde morluk; farklı iyileşme evrelerinde yaralar; sigara yanığı izleri.
- Büyüme geriliği, sürekli kirli ve bakımsız görünüm, aşı ve izlemlerin aksatılması, tedavi edilmeyen sağlık sorunları (ihmal).
- Çocukta aşırı korku, içe kapanma, yaşına uygun olmayan cinsel davranış ya da bilgi, ani davranış değişiklikleri. Şüphe durumunda çocuk ve aile suçlanmadan, sakin bir şekilde ve **hemen rehber hemşire/hekime** bildirilir; kurum prosedürü (yasal bildirim) işletilir.

6.4 Örnek: "18 aylık çocuk izlemini anlat"

> "Çocuğun kaydını incelerim: 12. ay aşıları yapılmış mı, son ölçümleri ve kansızlık taraması sonucu ne. Aileyi karşılayıp kendimi tanıtır, izin alırım. Beslenmesini (aile sofrasına katılıyor mu, ne kadar süt içiyor, anne sütü devam ediyor mu, biberon kullanıyor mu), uykusunu, tuvalet alışkanlıklarını, ekran süresini ve ailenin endişelerini sorarım. Yürüyüp yürümediğini, kaç kelime söylediğini, adı söylenince dönüp dönmediğini, istediği şeyi parmağıyla gösterip göstermediğini, göz teması kurup kurmadığını, taklit ve oyun becerilerini sorar ve gözlerim. Muayenede diş sayısına ve çürüğe, gözlerde kaymaya, cilde bakarım. Ağırlık, boy ve baş çevresini ölçüp persentile işlerim. Aşıya engel durumu sorgular, karma aşı pekiştirme dozunu ve Hepatit A aşısını kas içine yapar, OPA'yı ağızdan veririm; gözlem süresinde aileyi bekletirim. Seçici yemeyle baş etmeyi, düzenli öğünleri, diş fırçalamayı, iki yaşından önce ekran vermemeyi, zehirlenme ve düşmeleri önlemeyi anlatırım. Kaydeder, bir sonraki izlemin 24. ayda olduğunu ve o izlemde Hepatit A'nın ikinci dozunun yapılacağını söylerim. Yürümüyor, hiç kelime söylemiyor ya da göz teması kurmuyorsa hekime bildiririm."

7. ERİŞKİN, KRONİK HASTALIK VE YAŞLI İZLEMİ

7.1 Genel bilgiler

Erişkin izlemlerinin iki amacı vardır: **sağlıklı erişkinde risk faktörlerini erken saptamak** (yüksek tansiyon, şeker, obezite, sigara, kanser) ve **kronik hastalığı olan bireyi düzenli izleyerek komplikasyonları önlemek.** Aile hekimliğinde bu izlemler **Hastalık Yönetim Platformu (HYP)** üzerinden yürütülür; hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler risk, obezite, KOAH, kronik böbrek hastalığı ve yaşlı sağlığı için ayrı izlem modülleri vardır. Hedef değerleri ve tedaviyi hekim belirler; hemşire ölçüm yapar, eğitim verir, izlemi sürdürür ve hedef dışı durumları hekime bildirir.

7.2 Sağlıklı erişkinin periyodik izlemi

Her erişkinde (özellikle 18 yaşından sonra) periyodik olarak şunlar değerlendirilir:

- **Kan basıncı** (en az yılda bir; risk varsa daha sık)
- **Boy, kilo, BKİ ve bel çevresi**
- **Kan şekeri** (fazla kilolu, ailesinde diyabet olan, gebelikte şekeri çıkmış, hareketsiz, yüksek tansiyonlu kişilerde daha erken ve sık; diğerlerinde orta yaştan itibaren rehberin önerdiği aralıklarla)
- **Kolesterol** (kalp-damar riski olanlarda hekim önerisiyle)
- **Sigara, alkol, fiziksel aktivite ve beslenme alışkanlıkları**
- **Aile öyküsü** (erken yaşta kalp hastalığı, diyabet, kanser)
- **Yaşa uygun kanser taramaları:** Kadınlarda **30–65 yaş** arası **5 yılda bir HPV-smear**, **40–69 yaş** arası **2 yılda bir mamografi**; kadın ve erkeklerde **50–70 yaş** arası **2 yılda bir gaitada gizli kan testi** (ayrıca 10 yılda bir kolonoskopi)
- **Aşılar:** Td (beş doz tamamlandıktan sonra 10 yılda bir), risk grubundaysa influenza ve pnömokok

15–49 yaş kadın izlemi: Doğurganlık çağındaki kadınlarda ayrıca aile planlaması gereksinimi, gebelik planı (planlıyorsa folik asite gebelikten önce başlanması), Td aşı durumu, kansızlık belirtileri ve kanser taramaları değerlendirilir.

7.3 Kan basıncının doğru ölçülmesi (her izlemin temeli)

Yanlış ölçülen kan basıncı yanlış karara yol açar; bu yüzden teknik adım adım bilinmelidir:

1. Kişi ölçümden önceki **30 dakika** içinde sigara içmemiş, çay-kahve içmemiş, egzersiz yapmamış olmalı; mesanesi boş olmalıdır.
2. Sessiz bir ortamda **5 dakika oturarak dinlenir.**
3. **Sırtı desteklenmiş** olarak oturur, **ayakları yere düz basar**, bacak bacak üstüne atmaz; ölçüm sırasında **konuşmaz.**
4. Kol çıplaktır (sıkan giysi sıyrılmaz, çıkarılır), masaya desteklenmiştir ve **kalp hizasındadır.**
5. Kolun çevresine **uygun boyutta manşon** seçilir. **Dar manşon** değeri **olduğundan yüksek**, geniş manşon olduğundan düşük gösterir.
6. Manşon, alt kenarı dirsek çukurunun 2–3 cm üstünde kalacak ve ortası koldaki atardamarın üzerine gelecek şekilde sarılır.
7. Manuel ölçümde önce bilekteki nabız kaybolana kadar şişirilerek yaklaşık sistolik değer bulunur, sonra bunun 20–30 mmHg üstüne şişirilir ve **saniyede 2–3 mmHg** hızla indirilir. İlk duyulan ses **sistolik**, seslerin tamamen kaybolduğu nokta **diyastolik** basınçtır.
8. **1–2 dakika arayla 2–3 ölçüm** yapılıp ortalaması alınır.
9. **İlk değerlendirmede iki koldan** ölçülür; yüksek olan kol sonraki ölçümlerde kullanılır. Kollar arasında belirgin fark (10–15 mmHg'den fazla) hekime bildirilir.

10. Yaşlılarda ve diyabetlilerde ayağa kalktıktan **1 ve 3 dakika sonra** da ölçülür; sistolik basınçta 20, diyastolikte 10 mmHg ya da daha fazla düşme **ortostatik hipotansiyon**dur (baş dönmesi ve düşme riski).

Değerlendirme (ofis ölçümü): 120/80'in altı optimal; 120–129/80–84 normal; 130–139/85–89 yüksek normal; **140–159/90–99 evre 1**, **160–179/100–109 evre 2**, **180/110 ve üstü evre 3 hipertansiyon.** Evde ölçülen değerlerde 135/85 ve üstü yüksek kabul edilir.

7.4 Hipertansiyon izlemi

Öykü

- Baş ağrısı, baş dönmesi, burun kanaması, çarpıntı
- **Organ hasarı ve komplikasyon belirtileri:** göğüs ağrısı, nefes darlığı (kalp), görme bozukluğu (göz), ayaklarda şişlik ve idrar azalması (böbrek), konuşma bozukluğu, yüzde kayma, kol-bacakta güçsüzlük (inme)
- **İlaç kullanımı:** Hangi ilaçları, hangi dozda, günün hangi saatinde kullandığı; **ilaçlarını düzenli içip içmediği** (en sık sorun "kendimi iyi hissedince bırakıyorum" demektir); unutma nedenleri; yan etkiler (bazı tansiyon ilaçlarında kuru öksürük, ayak bileğinde şişlik, sık idrara çıkma, baş dönmesi görülebilir – kişi ilacını kendi kendine bırakmamalı, hekime söylemelidir); reçetesiz ağrı kesici kullanımı (tansiyonu yükseltebilir)
- **Yaşam tarzı:** Tuz kullanımı (sofrada tuz ekleme, turşu, salamura, hazır gıda, ekmek miktarı), beslenme, fiziksel aktivite, sigara, alkol, stres, uyku
- **Evde ölçüm** yapıyorsa kayıtları

Ölçümler

Kan basıncı (doğru teknikle, iki ölçüm ortalaması), nabız, kilo, BKİ, bel çevresi; gerekiyorsa kan şekeri. Ayaklarda ödeme bakılır.

Tahlil takibi

Hekimin istemine göre böbrek fonksiyonları (kreatinin), potasyum, idrarda albümin/protein, kolesterol, kan şekeri; gerekirse EKG. Hemşire sonuçların yapıldığını ve hekime ulaştığını takip eder.

Eğitim

- **Tuz:** Günde **5 gramdan az** (yaklaşık bir silme çay kaşığı). Tuzluğun sofradan kaldırılması; yemeğe tadına bakmadan tuz eklenmemesi; **gizli tuz kaynakları** (ekmek, peynir, zeytin, turşu, salamura, hazır çorba, salam-sucuk, cips, bazı maden suları); yiyecek etiketlerinde sodyum miktarına bakma; limon, sirke, nane, kekik gibi baharatlarla lezzetlendirme. Tat alma birkaç haftada az tuza alışır. Yemekleri eş ya da başka bir aile bireyi hazırlıyorsa eğitime o kişi de katılır.
- **Beslenme:** Sebze-meyve, tam tahıl, az yağlı süt ürünleri; doymuş yağ ve şekerin azaltılması.
- **Kilo verme ve fiziksel aktivite:** Haftada en az 150 dakika orta tempolu yürüyüş (örneğin haftada 5 gün 30 dakika).
- **Sigarayı bırakma**, alkolü bırakma ya da sınırlama.
- **İlaç uyumu:** İlacın her gün aynı saatte, kendini iyi hissetse de bırakılmadan kullanılması; haftalık ilaç kutusu, telefon alarmı, ilacı kahvaltı masasında tutma gibi hatırlatıcılar.
- **Evde doğru ölçüm** ve ölçüm günlüğü tutma.
- **Acil durumlar:** Kan basıncı çok yüksekken şiddetli baş ağrısı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, görme bozukluğu, konuşma bozukluğu, kol-bacakta güçsüzlük olursa **112**.

İzlem sıklığı

Kan basıncı kontrol altına alınana kadar sık aralıklarla (çoğunlukla 2–4 haftada bir), kontrol altına alındıktan sonra daha seyrek (çoğunlukla 3–6 ayda bir) izlenir; aralığı hekim belirler. Her izlemin sonunda bir sonraki izlem tarihi verilir.

7.5 Diyabet izlemi

Bilinmesi gerekenler

- **Tanı ölçütleri:** Açlık kan şekeri **126 mg/dl ve üstü**, şeker yükleme testinin 2. saatinde **200 mg/dl ve üstü**, **HbA1c %6,5 ve üstü** ya da diyabet belirtileriyle birlikte rastgele ölçümde 200 mg/dl ve üstü. Açlık şekerinin 100–125 mg/dl, HbA1c'nin %5,7–6,4 olması **prediyabet** (gizli şeker) demektir.
- **Belirtiler:** Çok idrara çıkma, çok su içme, çok yeme, açıklanamayan kilo kaybı, yorgunluk, bulanık görme, yaraların geç iyileşmesi, sık enfeksiyon.
- **Genel hedefler** (kişiye göre hekim belirler): **HbA1c %7'nin altında** (yaşlı ve kırılgan bireylerde daha esnek), yemek öncesi kan şekeri 80–130 mg/dl, yemekten 2 saat sonra 180 mg/dl'nin altında.

Öykü

- **Yüksek şeker belirtileri** (susama, sık idrar, yorgunluk) ve **düşük şeker atakları** (titreme, terleme, çarpıntı, açlık, baş dönmesi, sinirlilik, bulanık görme) – ne sıklıkta, ne zaman, ne yaptığı
- **İlaç/insülin kullanımı:** Dozlar, saatler, düzenlilik, insülini nereye ve nasıl yaptığı, kalem iğnesini değiştirip değiştirmediği, insülini nasıl sakladığı
- **Evde kan şekeri ölçümleri** ve günlüğü
- **Beslenme** (öğün düzeni, ekmek-pilav-makarna-tatlı miktarı, şekerli içecek), **fiziksel aktivite**
- **Ayaklar:** Uyuşma, karıncalanma, yanma, yara, renk değişikliği; ayaklarını her gün kontrol edip etmediği
- **Görme** bozukluğu, son göz muayenesi tarihi
- İdrar yolu ve cilt enfeksiyonları, diş eti sorunları
- Sigara

Ölçümler ve muayene

- Kan basıncı (diyabetlilerde kalp-damar riski yüksektir), kilo, BKİ, bel çevresi
- **Parmak ucu kan şekeri**
- **İnsülin uygulama bölgeleri:** Sürekli aynı bölgeye yapılan enjeksiyonlar ciltte yumru ve sertlik (lipohipertrofi) oluşturur ve insülinin emilimini bozar; bölgeler gözlenir ve elle yoklanır.
- **Ayak muayenesi:** Ayakkabı ve çoraplar çıkarılıp iki ayak karşılaştırılır: cilt (kuruluk, çatlak, nasır, yara, mantar, renk), tırnaklar, parmak aralar, deformite, ısı farkı, ayak nabızları; duyu kaybı yılda en az bir kez **monofilament** testi ile değerlendirilir. Yara, renk değişikliği, nabız alınamaması hemen hekime bildirilir.

Tahlil takibi

- **HbA1c:** Son 2–3 ayın şeker ortalamasını gösterir; hedefteyse yılda iki kez, hedefte değilse ya da tedavi değiştiyse 3 ayda bir.
- **Yılda en az bir kez:** Böbrek fonksiyonları ve **idrarda albümin**, kolesterol, **göz dibi muayenesi** (göz hekimi).
- Hemşire tetkiklerin zamanında yapılıp yapılmadığını takip eder.

Eğitim

- **Beslenme:** Düzenli öğünler, porsiyon kontrolü, tabağın yarısı sebze; tam tahıllar; şekerli içecek ve tatlıların sınırlandırılması; diyetisyene yönlendirme.

- **Fiziksel aktivite:** Haftada en az 150 dakika; egzersiz öncesi-sonrası şeker takibi (insülin kullananlarda hipoglisemi riski).
- **Düşük şeker (hipoglisemi) – 15-15 kuralı:** Kan şekeri **70 mg/dl'nin altında** ve kişi bilinçliyse **15 gram hızlı emilen şeker** alır (yarım su bardağı meyve suyu ya da 3–4 kesme şeker ya da 1 yemek kaşığı bal); **15 dakika sonra** tekrar ölçer; hâlâ 70'in altındaysa aynısını tekrarlar; düzelince bir sonraki öğün uzaksa bir dilim ekmek ya da birkaç bisküvi yer. **Bilinci kapalıysa** ağızdan hiçbir şey verilmez, **112** aranır.
- **Hasta olduğu günler:** İlacı/insülini kendi kendine bırakmaması, sık şeker ölçümü, bol sıvı, hekime danışma.
- **İnsülin uygulaması:** Karın (göbek çevresi hariç), uyluğun ön-dış yüzü, kolun arka-dış yüzü ve kalça bölgeleri; **bölgeler arasında ve aynı bölge içinde yer değiştirme**; her uygulamada yeni iğne; enjeksiyondan sonra iğneyi 10 saniye bekletme; açılmamış insülinin buzdolabında (dondurmadan), kullanılan kalemin oda ısısında yaklaşık 4 hafta saklanması. Kişiye uygulatarak kontrol edilir.
- **Ayak bakımı:** Ayakları her gün (tabanı aynayla) kontrol etme; ılık suyla yıkama ve parmak aralarını iyice kurulama; kuru cilde nemlendirici (parmak aralarına değil); tırnakları düz kesme; nasırları kendi kesmeme; **çıplak ayakla yürümeme**; sıcak su torbası, soba ile ayakları ısıtmama; dikişsiz pamuklu çorap ve rahat, geniş burunlu ayakkabı; ayakkabıyı giymeden önce içini kontrol etme; en küçük yarada bile başvurma.
- **Yıllık göz ve böbrek kontrollerinin** önemi; sigarayı bırakma; diş sağlığı.

7.6 KOAH ve astım izlemi

- **Öykü:** Nefes darlığı (hangi eforda), öksürük, balgam (miktar, renk), hırıltı, gece uyanma, son izlemden bu yana kaç atak geçirdiği ve hastaneye başvurup başvurmadığı, ilaçlarını nasıl kullandığı, sigara ve dumana maruziyet, mesleki toz-gaz maruziyeti.
- **Ölçümler:** Solunum sayısı, nabız, oksijen satürasyonu (varsa), kilo.
- **İnhaler tekniğinin gözlenmesi (en önemli kısım):** Hastaya ilacını hemşirenin yanında kullandırılır. Ölçülü doz inhalerde doğru teknik: kapağı aç, **çalkala**, nefesini tamamen ver, ağızlığı dudaklarla sıkıca kavra, **yavaş ve derin nefes alırken bir kez bas**, nefesini **yaklaşık 10 saniye tut**, yavaşça ver; ikinci doz için yarım-bir dakika bekle. Basma ile nefes almayı eşzamanlayamayanlara **aralık odacığı (spacer)** önerilir. Kuru toz inhalerler çalkalanmaz, içine nefes verilmez, **hızlı ve güçlü** nefes alınır. **Kortizonlu** inhalerlerden sonra ağız çalkalanır (ağızda mantarı önler).
- **Eğitim:** Sigarayı bırakma (en etkili tedavi); büzük dudak solunumu ve karından solunum; atak belirtileri (artan nefes darlığı, balgamın artması ya da renginin değişmesi, ateş) ve ne zaman başvurulacağı; **her yıl grip aşısı** ve pnömokok aşısı; düzenli fiziksel aktivite; ev içi dumandan ve sobadan korunma.

7.7 Obezite ve kalp-damar riski izlemi

- **BKİ = kilo (kg) / boy (m)²:** 18,5–24,9 normal, 25–29,9 fazla kilolu, 30 ve üstü obez (35–39,9 ikinci derece, 40 ve üstü üçüncü derece). Örneğin 82 kg, 1,65 m boyundaki kişide BKİ = 82 / (1,65 × 1,65) = 82 / 2,72 ≈ **30,1** (obez).
- **Bel çevresi**, kaburgaların alt kenarı ile kalça kemiğinin üst kenarı arasındaki orta noktadan, nefes verdikten sonra ölçülür. Kadında 80 cm'nin, erkekte 94 cm'nin üstü risk artışını; **kadında 88, erkekte 102 cm'nin üstü belirgin riski** gösterir.
- **Kalp-damar risk faktörleri:** İleri yaş, erkek cinsiyet, sigara, yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, obezite (özellikle karın bölgesinde), hareketsizlik, ailede erken yaşta kalp hastalığı, kronik böbrek hastalığı. 10 yıllık risk hekim tarafından risk skorlarıyla hesaplanır.
- **Eğitim:** Gerçekçi hedef (6 ayda mevcut kilonun %5–10'unu vermek); tabak modeli (tabağın yarısı sebze-meyve, dörtte biri tam tahıl, dörtte biri protein); şekerli içecek, hamur işi ve işlenmiş gıdanın azaltılması; porsiyon kontrolü; haftada 150–300 dakika orta tempolu aktivite ve haftada 2 gün kas güçlendirme; oturma süresini bölme; diyetisyen ve Sağlıklı Hayat Merkezine yönlendirme.
- **Kalp krizi belirtileri:** Göğüste baskı, sıkışma, ağrının kola-çeneye-sırta yayılması, soğuk terleme, nefes darlığı, bulantı → 112. Kadınlarda ve diyabetlilerde belirtiler daha silik olabilir.

- **İnme belirtileri:** Ani denge kaybı, görme kaybı, yüzde kayma, kolda-bacakta güçsüzlük, konuşma bozukluğu → **zaman kaybetmeden 112.**

7.8 Yaşlı izlemi (65 yaş ve üzeri)

Yaşlı izleminde amaç yalnızca hastalıkları izlemek değil, **yaşlının bağımsızlığını, işlevselliğini ve yaşam kalitesini korumak**tır. Bu nedenle yaşlıya **kapsamlı (bütüncül) değerlendirme** yapılır. Yaşlı izlemi ASM'de ya da – özellikle yatağa bağımlı ya da yalnız yaşayan yaşlılarda – **ev ziyaretiyle** yapılır. Ev ziyareti, ev ortamındaki düşme risklerini ve yaşam koşullarını görmeyi sağlar.

Kapsamlı değerlendirmenin bölümleri

1. Kronik hastalıklar ve ilaçlar: Hipertansiyon, diyabet, kalp, KOAH, böbrek, eklem hastalıkları, demans. **Tüm ilaçlar** (reçeteli, reçetesiz, bitkisel ürünler) gözden geçirilir. Pratik bir yöntem, yaşlıdan evdeki bütün ilaçları bir poşette getirmesini istemektir ("ilaç poşeti"). **Beş ve daha fazla ilaç kullanımı (polifarmasi)** ilaç etkileşimleri, yan etkiler, düşme ve ilaçların karıştırılması riskini artırır. Aynı etkili iki ilaç, gereksiz ya da yaşlıda uygunsuz olabilecek ilaçlar (örneğin uyku ilaçları, bazı ağrı kesiciler) saptanırsa hekime bildirilir. İlaç listesi büyük puntoyla yazılır, haftalık ilaç kutusu önerilir.

2. Günlük yaşam aktiviteleri (işlevsellik):

- **Temel günlük yaşam aktiviteleri (Katz):** Yıkanma, giyinme, tuvaleti kullanma, yataktan/sandalyeden kalkma (transfer), idrar-dışkı kontrolü, yemek yeme. Bu aktivitelerde yardıma ihtiyaç duyan yaşlı bakım desteği gerektirir.
- **Enstrümantal günlük yaşam aktiviteleri (Lawton-Brody):** Telefon kullanma, alışveriş, yemek hazırlama, ev işleri, çamaşır, ulaşım araçlarını kullanma, ilaçlarını kendi düzenleme, parasını yönetme. Bu aktivitelerdeki kayıplar genellikle temel aktivitelerdeki kayıplardan önce başlar ve bilişsel gerilemenin erken işareti olabilir.

3. Düşme riski: Son bir yılda düşüp düşmediği, düşme korkusu, baş dönmesi sorulur. **Kalk ve Yürü Testi** uygulanır: yaşlı kolçaklı bir sandalyede oturur, "başla" denince kalkar, kendi normal hızıyla **3 metre yürür**, döner, geri gelip oturur; süre ölçülür. **12–14 saniye ve üzeri** düşme riskinin yüksek olduğunu gösterir. Yürüyüşteki dengesizlik, tutunma ihtiyacı da not edilir. Ayakta ve otururak kan basıncı ölçülerek ortostatik hipotansiyon araştırılır.

4. Bilişsel durum: Unutkanlık, aynı soruları tekrar tekrar sorma, kaybolma, ilaçları karıştırma, para hesabında güçlük sorulur (yaşlıya ve yakınına). **Mini Mental Durum Testi** (30 puan üzerinden; genellikle 24'ün altı bilişsel bozukluk şüphesi, eğitim düzeyine göre yorumlanır) gibi testler kullanılabilir. Ani başlayan bilinç bulanıklığı (deliryum) ise enfeksiyon, ilaç, susuzluk gibi nedenlerle olabilir ve acildir.

5. Duygu durumu: Yaşlılarda depresyon sık görülür ama sıklıkla "yaşlılık" sanılıp gözden kaçar. İlgi kaybı, mutsuzluk, umutsuzluk, iştah ve uyku değişikliği sorulur; **Geriatrik Depresyon Ölçeği** (kısa form 15 soru; 5 ve üzeri puan depresyon şüphesi) kullanılabilir. Yalnızlık, eş kaybı ve yas sorulur.

6. Beslenme: Son aylarda istemeden kilo kaybı, iştahsızlık, öğün atlama, yalnız yaşayanlarda yemek hazırlayamama, diş-protez sorunları, çiğneme-yutma güçlüğü sorulur; kilo ve BKİ izlenir; **Mini Nütrisyonel Değerlendirme** kullanılabilir. Yaşlılarda susama hissi azaldığından **yeterli sıvı alımı** (özellikle yazın) ayrıca sorulur.

7. Görme ve işitme: Gözlük ve işitme cihazının kullanılıp kullanılmadığı, uygunluğu; katarakt belirtileri; işitme kaybı sosyal izolasyon ve bilişsel gerilemeyle ilişkilidir.

8. İdrar kaçırma: Mahremiyet içinde sorulur, çünkü yaşlılar çoğu zaman utandıkları için söylemez. Tedavi edilebilir bir sorundur; hekime yönlendirilir, pelvik taban egzersizleri ve düzenli tuvalet programı önerilir, cilt bakımı anlatılır.

9. Uyku: Uykuya dalma güçlüğü, gece sık uyanma, gündüz uyuklama; uyku ilacı kullanımı (düşme riski).

10. Ağrı: Kronik ağrı ve ağrı kesici kullanımı.

11. Cilt: Yatağa bağımlı yaşlıda bası yarası riski (kuyruk sokumu, topuklar, kalça) – cilt bütünlüğü, kızarıklık; **Braden Ölçeği** ile risk değerlendirmesi.

12. Sosyal durum ve destek: Kiminle yaşadığı, kimin bakım verdiği, ekonomik durum, sosyal ilişkiler. **Bakım veren kişinin yükü** de değerlendirilir; tükenmiş bakım verene destek kaynakları gösterilir.

13. Ev güvenliği (ev ziyaretinde): Kaygan halılar, yetersiz aydınlatma, banyoda tutunma barı ve kaydırmaz paspas olmaması, merdivenlerde tırabzan olmaması, eşikler, ortada duran kablolar, ısınma (soba ve karbonmonoksit riski), acil durumda yardım çağırabilme olanağı.

14. İhmal ve istismar: Açıklanamayan yaralar, bakımsızlık, ilaçlarının verilmemesi, parasının elinden alınması, korku belirtileri. Şüphede hekime/kuruma bildirilir.

15. Aşılar ve taramalar: Her yıl grip aşısı, **pnömokok aşısı**, Td (10 yılda bir); yaşa uygun kanser taramaları (mamografi 69 yaşına, gaitada gizli kan testi 70 yaşına kadar).

Yaşlıya ve ailesine anlatılacaklar

- **Düşmeleri önleme:** Kaygan halıların kaldırılması ya da altına kaydırmaz konması; yatak odasından tuvalete giden yolda **gece lambası**; banyoda tutunma barı ve kaydırmaz paspas; merdivenlerde tırabzan; sık kullanılan eşyaların el seviyesine alınması; **yataktan yavaş kalkma** (önce oturup 1–2 dakika bekleme, sonra kalkma); kaymaz tabanlı, arkası kapalı terlik/ayakkabı; gözlük ve işitme cihazının kullanılması; düzenli **denge ve kuvvet egzersizleri** (örneğin sandalyeye tutunarak parmak ucunda yükselme, oturup kalkma); ilaçların hekim tarafından gözden geçirilmesi; yanında telefon taşıma; düştüğünde nasıl yardım isteyeceği.
- **İlaç güvenliği:** İlaç listesi, haftalık ilaç kutusu, ilaçları kendi kendine bırakmama ya da başlamama, artan ilaçların atık kutusuna atılması.
- **Beslenme ve sıvı:** Yeterli protein (et, yumurta, süt ürünleri, baklagil), her gün sebze-meyve, susamasa da düzenli su içme (kalp-böbrek hastalığı nedeniyle sıvı kısıtlaması yoksa).
- **Fiziksel ve sosyal aktivite:** Her gün yürüyüş, sosyal etkinlikler, yaşlı merkezleri; zihinsel aktiviteler.
- **Sıcak ve soğuk havada korunma.**
- Gerekirse **evde sağlık hizmetleri**, sosyal hizmetler ve bakım destek kaynaklarına yönlendirme.

Bir sonraki izlem

Yaşlının sağlık durumu, kronik hastalıkları ve risklerine göre planlanır; düşme riski yüksek, yalnız yaşayan ya da yeni sorun saptanan yaşlıda daha kısa aralıklarla (gerekirse ev ziyaretiyle) izlem yapılır.

7.9 Örnek: "70 yaşında, hipertansiyon ve diyabeti olan yaşlının izlemini anlat"

> "Önce kaydını incelerim: hangi ilaçları kullandığını, son kan basıncı ve HbA1c değerlerini, en son ne zaman göz ve böbrek kontrolü yapıldığını, aşılarını. Kendimi tanıtıp izin alırım. Baş ağrısı, baş dönmesi, göğüs ağrısı, nefes darlığı, görme bozukluğu, ayaklarda uyuşma ya da yara, düşük şeker atakları olup olmadığını sorarım. İlaçlarını nasıl kullandığını, unutup unutmadığını, evdeki bütün ilaçlarını sorarım; beş ilacın üzerindeyse polifarmasi açısından hekime bildiririm. Tuz ve beslenme alışkanlığını, yürüyüş yapıp yapmadığını, son bir yılda düşüp düşmediğini sorarım. Kan basıncını doğru teknikle iki kez ölçüp ortalamasını alırım, ayakta da ölçerek ortostatik hipotansiyona bakarım. Kilo, bel çevresi ve parmak ucu kan şekerini ölçerim. Ayaklarını çıplak olarak inceler, insülin kullanıyorsa enjeksiyon bölgelerine bakarım. Kalk ve Yürü testi yaparım; 14 saniyenin üzerindeyse düşme riski yüksektir.

> Günlük yaşam aktivitelerinde, hafızasında ve ruh halinde sorun olup olmadığını sorarım. Tuz kısıtlamasını, ilaç uyumunu, 15-15 kuralını, ayak bakımını ve evde düşmeyi önlemeyi anlatır, anlattıklarımı ona tekrar ettiririm. Grip ve pnömokok aşısını, yaşına uygunsa kolorektal kanser taramasını kontrol ederim. Bulguları kaydeder, hedef dışı değerleri hekime bildirir ve bir sonraki izlem tarihini veririm."

8. EK: İZLEMLERDE YAPILAN AŞILAR (ÖZET)

Aşılar izlemlerin bir parçası olduğu için sırasıyla bilinmelidir (2025'te beşli karma aşı yerine altılı karma aşıya geçilmiştir):

- **Doğumda:** Hepatit B
- **2. ay:** BCG, altılı karma (1), KPA (1)
- **4. ay:** Altılı karma (2), KPA (2)
- **6. ay:** Altılı karma (3), OPA (1)
- **12. ay:** KPA pekiştirme, KKK (1), suçiçeği
- **18. ay:** Karma aşı pekiştirme, OPA (2), Hepatit A (1)
- **24. ay:** Hepatit A (2)
- **48. ay:** KKK (2), DaBT-İPA
- **13 yaş:** Td
- **Gebelik:** Aşılanma durumuna göre Td (Td1 4. ayda, Td2 en az 4 hafta sonra, Td3 6 ay sonra, Td4 ve Td5 birer yıl arayla)
- **Erişkin:** Td 10 yılda bir; risk gruplarında ve 65 yaş üstünde grip (her yıl) ve pnömokok

Aşılarla ilgili hatırlanacak kurallar:

- Hafif hastalık, hafif ateş, antibiyotik kullanımı, prematürite, emzirme aşıya engel değildir; orta-ağır hastalıkta aşı ertelenir.
- Canlı aşılar (BCG, OPA, KKK, suçiçeği) gebelikte ve ağır bağışıklık yetmezliğinde yapılmaz.
- Prematüre bebekler doğum haftasına göre değil, **takvim yaşına göre** aşılanır.
- Aşıdan sonra en az 15 dakika (risk varsa 30 dakika) gözlem yapılır.
- Aşılar +2 / +8 °C'de saklanır; buzdolabı ısısı günde en az iki kez kaydedilir.

9. EK: İZLEMLERDE VERİLEN DESTEKLER (ÖZET)

- **Bebekte D vitamini:** Doğumdan itibaren 1 yaşın sonuna kadar, günde 400 IU (3 damla).
- **Bebekte demir:** 4. ayın başından 12. ayın sonuna kadar, günde 1 mg/kg.
- **Gebede folik asit:** Gebelik öncesinden itibaren ilk 12 hafta boyunca, günde 400 mikrogram.
- **Gebede D vitamini:** 12. haftadan sonra doğumdan sonraki 6. ayın sonuna kadar, günde 1200 IU.
- **Gebede demir:** 16. haftadan doğumdan sonraki 3. ayın sonuna kadar, günde 40–60 mg.

10. KENDİNİ TEST ET

Gebe izlemi

1. Gebe izlemleri kaç tane ve hangi haftalarda yapılır?
2. Birinci izlemde öyküde neleri sorarsın? Neden son adet tarihi bu kadar önemlidir?
3. SAT 14 Eylül 2026 olan gebenin tahmini doğum tarihini hesapla. (Cevap: 21 Haziran 2027)
4. Fundus 20–22. haftada nerededir? 36. haftada nerededir? McDonald kuralı nedir?
5. Hangi haftada OGTT yapılır, sonuçlar nasıl yorumlanır?
6. Gebe bebek hareketlerini nasıl sayar, ne zaman başvurmalıdır?
7. 32 haftalık gebede kan basıncı 150/95 ve baş ağrısı varsa ne düşünür, ne yaparsın?
8. Leopold manevralarının her biri neyi gösterir?
9. Gebelikteki tehlike belirtilerini say.

Lohusa izlemi 10. Lohusa izlemleri ne zaman yapılır? Neden bebek izlemleriyle birlikte planlanır? 11. Doğumdan sonra 5. günde fundus nerede olmalı? 14. günde? 12. Loşianın türleri ve süreleri nelerdir? Hangi loşia özellikleri tehlikelidir? 13. Doğru emzirme tutuşu ve kavramasının belirtileri nelerdir? 14. Lohusa hüznünü doğum sonu depresyondan nasıl ayırırsın? 15. Gebelikte şekeri çıkan anneye doğumdan sonra ne önerirsin?

Bebek izlemi 16. 0–1 yaşta kaç izlem vardır, zamanları nedir? 17. Yenidoğan ev ziyaretinde baştan aşağı neleri değerlendirirsin? 18. Bebeğin yeterli süt aldığını nasıl anlarsın? 19. Hangi sarılık tehlikelidir? 20. 15. gün izleminde hangi üç şeyi mutlaka kontrol edersin? 21. 2., 4. ve 6. ay izlemlerinde hangi aşılar yapılır? 22. Demir desteği ne zaman başlar? Aileye ne anlatırsın? 23. Ek gıdaya nasıl başlanır? Bir yaşından önce hangi besinler verilmez? 24. 9 aylık bebekte hangi gelişim basamaklarını beklersin?

Çocuk ve ergen izlemi 25. 1–6 yaş arasında hangi aylarda izlem yapılır? 26. 12. ay izleminde hangi aşılar yapılır ve hangi destekler sonlandırılır? 27. 18. ayda otizm açısından neleri gözlersin? 28. Tuvalet eğitimine hazır olma belirtileri nelerdir? 29. Kan basıncı ölçümüne hangi yaşta başlanır? 30. Erken ve gecikmiş ergenlik sınırları nelerdir? 31. Ergenle görüşürken gizlilik nasıl açıklanır?

Erişkin ve yaşlı izlemi 32. Doğru kan basıncı ölçümünün basamakları nelerdir? 33. Hipertansiyonlu bireyde öyküde neleri sorarsın? 34. Diyabetli bireyin ayak muayenesinde nelere bakarsın? 35. 15-15 kuralını anlat. 36. Yaşlının kapsamlı değerlendirmesinde hangi alanlar değerlendirilir? 37. Kalk ve Yürü testi nasıl yapılır, nasıl yorumlanır? 38. Yaşlının evinde düşmeyi önlemek için neler önerirsin?